

Bunga Rampai **PENGABDIAN DAN PERAN NYATA** TENAGA KESEHATAN DALAM MASYARAKAT

Nurul Lidya • Dwi Setiyawati • Yenda Hasnita • Sri Musfiroh

Editor : Kristy Mellyya Putri



BUNGA RAMPAI

PENGABDIAN DAN PERAN NYATA TENAGA KESEHATAN DALAM MASYARAKAT

Penulis:

Nurul Lidya, SST., Bdn., M.Kes.

Dwi Setiyawati, S.St., M.Fis.

Yenda Hasnita, S.Tr.Keb., M.Keb.

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

Editor:

Kristy Mellyya Putri, SST., Bdn., M.Kes.



Bunga Rampai Pengabdian Dan Peran Nyata Tenaga Kesehatan Dalam Masyarakat

Penulis:

Nurul Lidya, SST., Bdn., M.Kes.

Dwi Setiyawati, S.St., M.Fis.

Yenda Hasnita, S.Tr.Keb., M.Keb.

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

Editor: Kristy Melly Putri, SST., Bdn., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7556-73-8

Cetakan Pertama : Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga bookchapter berjudul “Bunga Rampai: Pengabdian dan Peran Nyata Tenaga Kesehatan dalam Masyarakat” dapat disusun dan diselesaikan. Kehadiran bunga rampai ini merupakan wujud komitmen untuk memperkaya literatur serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya pengabdian tenaga kesehatan dalam membangun derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman geografis, sosial-budaya, dan tantangan kesehatan yang dinamis.

Tenaga kesehatan memiliki peran strategis tidak hanya dalam pelayanan kuratif di fasilitas kesehatan, tetapi juga dalam upaya promotif dan preventif yang berlangsung langsung di tengah masyarakat. Berbagai persoalan kesehatan—seperti stunting, penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lansia, hingga kesehatan mental—tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan klinis semata. Diperlukan keterlibatan aktif tenaga kesehatan untuk melakukan edukasi, pendampingan, pemberdayaan keluarga, penguatan komunitas, serta kolaborasi lintas sektor agar perubahan perilaku dan lingkungan yang mendukung kesehatan dapat tercapai. Di sinilah pengabdian masyarakat menjadi ruang nyata bagi tenaga kesehatan untuk menerjemahkan ilmu, keterampilan, dan nilai profesi dalam tindakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Bunga rampai ini disusun untuk menghadirkan beragam perspektif, pengalaman, serta praktik baik pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari berbagai profesi. Setiap pembahasan di dalamnya diupayakan tidak hanya memuat konsep dan landasan teori, tetapi juga menonjolkan pendekatan aplikatif—mulai dari identifikasi masalah kesehatan, perencanaan program berbasis kebutuhan lokal, implementasi kegiatan, hingga evaluasi dan strategi keberlanjutan. Dengan demikian, pembaca diharapkan memperoleh gambaran yang utuh bahwa pengabdian masyarakat bukan sekadar aktivitas program, melainkan proses kolaboratif yang menuntut sensitivitas budaya, keterampilan komunikasi, dan kemampuan membangun kemitraan dengan keluarga, kader kesehatan, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Bookchapter ini ditujukan bagi mahasiswa bidang kesehatan, tenaga kesehatan pemula, praktisi, pendidik, dan pengelola program sebagai referensi dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengabdian yang lebih terarah, efektif, dan berdaya guna. Harapannya, bunga rampai ini dapat menjadi inspirasi sekaligus panduan untuk

memperkuat peran tenaga kesehatan sebagai agen perubahan, pendamping komunitas, dan penggerak pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian kesehatan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan bunga rampai ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi kelengkapan materi maupun keluasan konteks pengabdian di berbagai daerah. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada kesempatan berikutnya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi pemikiran, dan masukan dalam proses penyusunan karya ini.

Akhir kata, semoga “Bunga Rampai: Pengabdian dan Peran Nyata Tenaga Kesehatan dalam Masyarakat” dapat memberikan manfaat yang luas, meningkatkan semangat pengabdian, serta menjadi salah satu upaya dalam memperkuat mutu pelayanan kesehatan berbasis komunitas di Indonesia.

Maret, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 PENGABDIAN TENAGA KEBIDANAN DALAM KESEHATAN

IBU DAN ANAK.....	1
Bdn. Nurul Lidya, SST., M.Kes.....	1
A. Pendahuluan / Prolog.....	1
B. Konsep Pengabdian Kebidanan.....	2
C. Peran Kebidanan dalam Kesehatan Ibu	5
D. Peran Kebidanan dalam Kesehatan Anak.....	7
E. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat	8
F. Integrasi dengan Sistem Kesehatan	9
G. Simpulan.....	9
H. Referensi.....	10
I. Glosarium.....	12

CHAPTER 2 EDUKASI DAN PROMOSI KESEHATAN BERBASIS

KOMUNITAS	13
Dwi Setiyawati, S.St.,M.Fis.	13
A. Pendahuluan / Prolog.....	13
B. Konseptualisasi Edukasi dan Promosi Kesehatan.....	15
C. Kerangka Teoretis Pendekatan Berbasis Komunitas	17
D. Strategi Implementasi Edukasi dan Promosi Kesehatan Berbasis Komunitas.....	19
E. Tantangan dan Hambatan Implementasi.....	21
F. Model Adaptif dan Berkelanjutan dalam Promosi Kesehatan Komunitas.....	23
G. Implikasi Praktis bagi Tenaga Kesehatan	25
H. Simpulan.....	27
I. Referensi.....	28
J. Glosarium.....	31

CHAPTER 3 KOLABORASI TENAGA KESEHATAN DALAM PENGABDIAN

MASYARAKAT	35
Yenda Hasnita, S.Tr.Keb., M.Keb.....	35
A. Pendahuluan / Prolog.....	35
B. Konsep Kolaborasi Tenaga Kesehatan	36

C. Landasan Teoritis Kolaborasi Tenaga Kesehatan.....	39
D. Peran Tenaga Kesehatan dalam Kolaborasi Pengabdian Masyarakat	41
E. Bentuk dan Model Kolaborasi dalam Pengabdian Masyarakat	44
F. Implementasi Kolaborasi pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat.....	46
G. Tantangan dalam Kolaborasi Tenaga Kesehat	47
H. Strategi Penguatan Kolaborasi Tenaga Kesehatan	48
I. Dampak Kolaborasi terhadap Keberhasilan Pengabdian Masyarakat	50
J. Simpulan.....	51
K. Referensi.....	51
L. Glosarium.....	52

CHAPTER 4 DAMPAK PENGABDIAN TERHADAP PENINGKATAN

KESEHATAN MASYARAKAT.....53

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.53

A. Pendahuluan / Prolog.....	53
B. Konsep dan Landasan Teoritis.....	54
C. Dampak Pengabdian terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat	56
D. Simpulan.....	57
E. Referensi.....	59
F. Glosarium.....	61

PROFIL PENULIS63

CHAPTER 1

PENGABDIAN TENAGA KEBIDANAN DALAM KESEHATAN IBU DAN ANAK

Bdn. Nurul Lidya, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan / Prolog

Kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan indikator kunci dalam menilai derajat kesehatan masyarakat dan keberhasilan pembangunan kesehatan suatu negara. Secara global, World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa sekitar 287.000 perempuan meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan pada tahun 2020, dengan lebih dari 94% kematian terjadi di negara berkembang (WHO, 2023). Selain itu, angka kematian bayi global masih mencapai sekitar 2,3 juta kematian per tahun, yang sebagian besar terjadi pada periode neonatal (WHO, 2023). Data ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak masih menjadi tantangan besar yang memerlukan keterlibatan aktif tenaga kesehatan di tingkat komunitas.

Di Indonesia, kesehatan ibu dan anak juga menjadi prioritas utama dalam sistem kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa kehamilan berisiko, persalinan tidak aman, serta kurang optimalnya perawatan ibu nifas dan bayi baru lahir masih menjadi penyebab utama tingginya morbiditas dan mortalitas ibu dan anak (Kemenkes RI, 2023). Selain itu, masalah gizi pada ibu hamil dan balita berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka stunting, yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia (Sharma & Singh, 2025).

Tenaga kebidanan memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan tersebut karena bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya pada layanan kesehatan primer. Menurut Lowdermilk et al. (2024), bidan berperan penting dalam memberikan asuhan kebidanan berkelanjutan

mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi dan balita. Lebih dari 80% komplikasi kehamilan dan persalinan sebenarnya dapat dicegah melalui pelayanan antenatal yang berkualitas, deteksi dini faktor risiko, serta edukasi kesehatan yang tepat kepada ibu dan keluarga (Pillitteri, 2024).

Pengabdian tenaga kebidanan dalam kesehatan ibu dan anak merupakan wujud nyata dari peran profesional bidan yang tidak hanya berfokus pada tindakan klinis, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif berbasis masyarakat. Kegiatan pengabdian ini meliputi pelayanan antenatal terpadu, pendampingan ibu hamil berisiko, kelas ibu hamil, perawatan ibu nifas dan bayi baru lahir, promosi ASI eksklusif, pemantauan tumbuh kembang balita, serta edukasi pencegahan masalah gizi dan stunting. Pendekatan komunitas ini terbukti meningkatkan cakupan pelayanan KIA dan memperkuat keterlibatan keluarga dalam menjaga kesehatan ibu dan anak (Fraser & Cooper, 2023).

Dalam konteks sosial budaya masyarakat, keberhasilan pengabdian kebidanan sangat dipengaruhi oleh pemahaman bidan terhadap nilai, norma, dan kebiasaan lokal. McKinney et al. (2023) menekankan bahwa intervensi kesehatan ibu dan anak yang disesuaikan dengan konteks budaya masyarakat lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan perilaku sehat. Oleh karena itu, bidan dituntut memiliki kompetensi komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta kemampuan bekerja sama dengan kader kesehatan dan lintas sektor.

B. Konsep Pengabdian Kebidanan

Pengabdian tenaga kebidanan merupakan wujud nyata dari peran profesional bidan dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Pengabdian ini dipahami sebagai serangkaian tindakan profesional yang dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan komunitas untuk meningkatkan, memelihara, serta memulihkan kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Lowdermilk et al., 2024; Fraser & Cooper, 2023). Dalam konteks pelayanan kesehatan primer,

pengabdian kebidanan menjadi bagian penting dari upaya penguatan sistem kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita.

Salah satu komponen utama dalam pengabdian tenaga kebidanan adalah edukasi kesehatan kepada ibu hamil, ibu nifas, dan keluarga balita. Edukasi kesehatan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga mengenai kehamilan sehat, persalinan aman, perawatan masa nifas, pemberian ASI eksklusif, pemenuhan gizi seimbang, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Edukasi yang diberikan oleh bidan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan partisipatif, sehingga mampu mendorong perubahan perilaku kesehatan secara berkelanjutan (Pillitteri, 2024; Kementerian Kesehatan RI, 2023). Sebagai contoh, bidan di wilayah kerja puskesmas dapat menyelenggarakan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita yang berisi diskusi interaktif mengenai tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, dan pencegahan masalah gizi pada anak.

Selain edukasi kesehatan, pengabdian kebidanan juga mencakup promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai upaya preventif dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Promosi PHBS meliputi praktik kebersihan diri, sanitasi lingkungan, penggunaan air bersih, pemenuhan gizi seimbang, serta pencegahan penyakit menular. Penerapan PHBS terbukti berkontribusi dalam menurunkan risiko infeksi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, serta mencegah kejadian penyakit pada bayi dan balita (McKinney et al., 2023; WHO, 2023). Contoh kegiatan pengabdian dalam aspek ini adalah penyuluhan tentang cuci tangan pakai sabun dan kebersihan lingkungan rumah yang dilakukan bidan bersama kader kesehatan saat kegiatan posyandu.

Pengabdian tenaga kebidanan juga diwujudkan melalui penjangkauan layanan antenatal, persalinan, dan pasca-persalinan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Penjangkauan ini bertujuan memastikan setiap ibu memperoleh pelayanan kebidanan yang aman dan bermutu sejak masa kehamilan hingga masa nifas. Bidan dapat melakukan

kunjungan rumah, pelayanan keliling, atau pelayanan terpadu berbasis posyandu untuk menjangkau ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Pendekatan ini sangat penting dalam mendeteksi dini komplikasi, memperkuat sistem rujukan, serta menjamin kesinambungan asuhan kebidanan atau continuity of care (Lowdermilk et al., 2024; WHO, 2023). Sebagai contoh, bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu nifas minggu pertama untuk memantau kondisi ibu dan bayi serta memberikan konseling menyusui.

Aspek penting lainnya dalam pengabdian kebidanan adalah pemberdayaan kader kesehatan sebagai bentuk penguatan dukungan lokal di masyarakat. Kader kesehatan berperan sebagai mitra bidan dalam menyampaikan informasi kesehatan, memantau kondisi ibu dan anak, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan. Melalui pelatihan dan pendampingan kader, bidan membantu menciptakan sistem dukungan berbasis komunitas yang berkelanjutan dan mampu menjangkau keluarga secara lebih luas (Fraser & Cooper, 2023; Kementerian Kesehatan RI, 2024). Contoh pemberdayaan kader adalah pelatihan kader posyandu dalam penimbangan balita, pencatatan KMS, serta edukasi sederhana tentang gizi dan stimulasi tumbuh kembang anak.

Seluruh rangkaian pengabdian tenaga kebidanan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan kesadaran komunitas dan pemberdayaan keluarga. Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan. Selain itu, pengabdian kebidanan dilakukan melalui kolaborasi yang erat dengan fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas dan posyandu, serta kerja sama lintas sektor. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan efektivitas rujukan, serta memastikan kesinambungan pelayanan dari tingkat komunitas hingga fasilitas kesehatan (WHO, 2023; Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Dengan pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan kolaboratif, pengabdian tenaga kebidanan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata

dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional secara berkelanjutan.

C. Peran Kebidanan dalam Kesehatan Ibu

Peran tenaga kebidanan dalam kesehatan ibu merupakan bagian penting dari upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta meningkatkan kualitas hidup perempuan sepanjang siklus reproduksi. Bidan memiliki kompetensi profesional untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkesinambungan sejak masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Pendekatan ini menempatkan bidan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu di tingkat pelayanan kesehatan primer dan komunitas (Lowdermilk et al., 2024; Fraser & Cooper, 2023).

1. Layanan Antenatal Terpadu

Layanan antenatal terpadu merupakan salah satu bentuk peran utama bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Antenatal care bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan janin, mendeteksi dini faktor risiko, serta mencegah terjadinya komplikasi kehamilan yang dapat membahayakan ibu dan bayi (WHO, 2023). Pelayanan antenatal yang berkualitas dan berkesinambungan terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan angka kelangsungan hidup ibu dan bayi (Lowdermilk et al., 2024).

Dalam praktiknya, bidan memberikan pemeriksaan kehamilan secara teratur yang meliputi pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi fundus uteri, serta penilaian kondisi umum ibu hamil. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini risiko kehamilan seperti anemia, hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia, dan gangguan pertumbuhan janin (Pillitteri, 2024). Selain pemeriksaan fisik, bidan juga memberikan konseling gizi kepada ibu hamil untuk memastikan kecukupan asupan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan janin dan kesehatan ibu, serta mempersiapkan ibu secara fisik dan psikologis menghadapi persalinan (McKinney et al., 2023).

Edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan juga menjadi bagian penting dari layanan antenatal terpadu. Bidan memberikan pemahaman kepada ibu dan keluarga mengenai tanda-tanda yang memerlukan pertolongan segera, seperti perdarahan, nyeri hebat, penurunan gerak janin, dan pembengkakan ekstremitas. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan keluarga dan mendorong pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk mencari pertolongan medis (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Sebagai contoh, dalam kegiatan kelas ibu hamil, bidan menyampaikan materi tanda bahaya kehamilan melalui diskusi interaktif dan simulasi sederhana agar mudah dipahami oleh peserta.

2. Asuhan Persalinan Aman

Asuhan persalinan aman merupakan salah satu kontribusi utama tenaga kebidanan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Bidan memiliki kompetensi untuk memberikan asuhan persalinan normal yang aman, bersih, dan bermutu sesuai dengan standar pelayanan kebidanan dan prinsip keselamatan pasien (Fraser & Cooper, 2023). Asuhan persalinan yang diberikan bidan tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis dan emosional ibu.

Selama proses persalinan, bidan bertanggung jawab menjaga keselamatan ibu dan bayi melalui pemantauan kemajuan persalinan, kondisi ibu, dan kesejahteraan janin. Pemantauan yang dilakukan secara sistematis memungkinkan bidan mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau komplikasi persalinan (Pillitteri, 2024). Bidan juga terlatih untuk menangani persalinan normal dengan pendekatan asuhan sayang ibu dan bayi, yang menekankan kenyamanan, dukungan emosional, serta penghormatan terhadap pilihan ibu selama persalinan (Lowdermilk et al., 2024).

Selain itu, bidan memiliki peran penting dalam mengidentifikasi komplikasi persalinan dan melakukan rujukan secara tepat waktu sesuai sistem rujukan yang berlaku. Kemampuan bidan dalam mengenali tanda-tanda kegawatdaruratan obstetri dan mengambil keputusan klinis yang cepat merupakan faktor kunci

dalam mencegah keterlambatan penanganan yang dapat berakibat fatal (WHO, 2023). Contoh implementasi di lapangan adalah bidan yang segera merujuk ibu dengan tanda preeklamsia berat ke rumah sakit rujukan setelah melakukan penanganan awal sesuai kewenangannya.

D. Peran Kebidanan dalam Kesehatan Anak

Selain berperan dalam kesehatan ibu, tenaga kebidanan juga memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan anak, terutama pada masa bayi baru lahir dan balita. Asuhan kebidanan pada anak bertujuan memastikan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak secara optimal sejak awal kehidupan (McKinney et al., 2023).

1. Perawatan Bayi Baru Lahir

Perawatan bayi baru lahir merupakan bagian integral dari pelayanan kebidanan yang berkontribusi langsung terhadap penurunan angka kematian neonatal. Bidan bertanggung jawab dalam pelaksanaan inisiasi menyusui dini (IMD), pemeriksaan kondisi vital bayi, serta pencegahan hipotermia dan infeksi pada bayi baru lahir (WHO, 2023). IMD terbukti meningkatkan keberhasilan menyusui dan memberikan perlindungan imunologis awal bagi bayi (Lowdermilk et al., 2024).

Selain IMD, bidan melakukan pemeriksaan awal bayi untuk menilai kondisi pernapasan, suhu tubuh, denyut jantung, serta refleks dasar bayi. Pencegahan hipotermia dilakukan melalui pengeringan segera, kontak kulit ibu dan bayi, serta menjaga suhu lingkungan yang hangat. Upaya pencegahan infeksi dilakukan dengan penerapan prinsip kebersihan dan perawatan tali pusat yang benar (Pillitteri, 2024). Contoh praktik di lapangan adalah bidan yang memberikan edukasi perawatan tali pusat kepada ibu sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas kesehatan.

2. Pemantauan Tumbuh Kembang Anak

Pemantauan tumbuh kembang anak merupakan salah satu bentuk pengabdian kebidanan dalam mendukung kualitas hidup anak jangka panjang. Bidan melakukan penimbangan berat badan, pengukuran panjang atau tinggi badan, serta pemantauan perkembangan anak sesuai usia pada kegiatan posyandu atau kunjungan rumah (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Pemantauan ini bertujuan mendeteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan, termasuk masalah gizi dan risiko stunting.

Selain pemantauan fisik, bidan memberikan konseling gizi kepada ibu dan keluarga mengenai pemberian ASI, MP-ASI yang tepat, serta pola makan seimbang sesuai usia anak. Bidan juga memberikan edukasi tentang stimulasi dini untuk mendukung perkembangan motorik, bahasa, dan sosial anak (McKinney et al., 2023). Sebagai contoh, bidan mengajarkan orang tua cara melakukan stimulasi sederhana seperti mengajak anak berbicara dan bermain sesuai tahap perkembangan usia.

E. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, tenaga kebidanan berperan sebagai *agent of change* yang mendorong terjadinya perubahan perilaku kesehatan di tingkat keluarga dan komunitas. Bidan membimbing kader posyandu sebagai mitra kerja dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta menyelenggarakan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam menjaga kesehatan (Fraser & Cooper, 2023).

Selain kegiatan tatap muka, bidan juga dapat menyebarkan informasi kesehatan melalui media lokal, seperti poster, leaflet, atau media sosial komunitas, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Penguatan dukungan keluarga selama masa nifas dan menyusui juga menjadi fokus pengabdian kebidanan, karena dukungan keluarga terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui dan

pemulihan ibu pasca-persalinan (WHO, 2023). Upaya edukasi dan pemberdayaan ini berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga secara berkelanjutan.

F. Integrasi dengan Sistem Kesehatan

Pengabdian tenaga kebidanan tidak hanya berlangsung di tingkat komunitas, tetapi juga terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan primer. Integrasi ini memungkinkan rujukan ibu hamil risiko tinggi berjalan secara efektif, memastikan kesinambungan asuhan, serta menjamin keamanan ibu dan bayi (Lowdermilk et al., 2024). Bidan berperan dalam pencatatan dan pelaporan data kesehatan ibu dan anak sehingga informasi yang tersedia akurat, konsisten, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program kesehatan.

Selain itu, melalui integrasi dengan puskesmas dan posyandu, bidan memastikan bahwa program-program pemerintah seperti imunisasi, pelayanan keluarga berencana, dan program kesehatan ibu dan anak lainnya dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Dengan integrasi yang kuat antara pelayanan kebidanan dan sistem kesehatan, pengabdian bidan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

G. Simpulan

Pengabdian tenaga kebidanan dalam kesehatan ibu dan anak merupakan wujud nyata kontribusi tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui peran profesionalnya, bidan tidak hanya memberikan pelayanan klinis, tetapi juga menjalankan fungsi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi dengan kebutuhan komunitas. Asuhan kebidanan yang berkesinambungan sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi dan pemantauan tumbuh kembang anak menjadi fondasi penting dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak.

Layanan antenatal terpadu dan asuhan persalinan aman yang diberikan bidan terbukti berkontribusi terhadap pencegahan komplikasi dan peningkatan keselamatan ibu dan bayi. Selain itu, peran bidan dalam perawatan bayi baru lahir serta pemantauan tumbuh kembang anak mendukung tercapainya generasi yang sehat dan berkualitas. Melalui kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, bidan berperan sebagai agen perubahan yang mendorong peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan keluarga dan komunitas.

Integrasi pengabdian kebidanan dengan sistem pelayanan kesehatan primer memperkuat efektivitas layanan, memastikan kesinambungan asuhan, serta mendukung keberhasilan program-program kesehatan nasional. Dengan demikian, pengabdian tenaga kebidanan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memberikan kontribusi strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

H. Referensi

- Adinda F. Zahra, Aramico, B., & Gusweni, M. (2025). Implementasi program kesehatan ibu dan anak (KIA): Studi kasus di Puskesmas Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025. *SehatMas: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 4(4), 1297–1309.
- Dina Putriati, Suryani, L., & Zaman, C. (2025). Analysis of maternal and child health book utilization among pregnant women. *Lentera Perawat*, 6(1), 123–130.
- Fraser, D. M., & Cooper, M. A. (2023). *Myles textbook for midwives*. Elsevier.
- Fitra Duhita, Irianti, B., Halida, E. M., Hartiningtiyaswati, S., Yulianti, N., Prabandari, F., & Yulita, N. (2023). A survey of midwifery care needs in mother and child health care. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 15(3), e1064.
- Juwita, & Nurhaeda. (2025). Menjaga kesehatan ibu dan anak sejak dini: Kunci generasi sehat masa depan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Buku ajar kesehatan ibu dan anak*. Kemenkes RI.

- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R. (2024). *Maternity and women's health care*. Wolters Kluwer.
- Mahmud, R., Aslinda, A., Samiun, Z., Mustary, M., Kai, F., & Surianti, S. (2024). Clean water availability and access to health services on maternal and child health status. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 6(3), 510–518.
- McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., Nelson, K. A., & Ashwill, J. W. (2023). *Foundations of maternal-newborn and women's health nursing*. Elsevier.
- Nishimura, E., Rahman, M. O., Ota, E., Toyama, N., & Nakamura, Y. (2023). Role of maternal and child health handbook on improving maternal, newborn, and child health outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Children*, 10(3), 435.
- Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Cashion, K., Alden, K. R., & Olshansky, E. (2023). *Maternal child nursing care* (7th ed.). Elsevier.
- Pillitteri, A. (2024). *Maternal and child health nursing: Care of the childbearing and childrearing family*. Wolters Kluwer.
- Riana, A., Harun, I., Irawan, G. C., & Amalia, E. (2024). Maternal nutrition education based on maternal and child health (MCH) book: Its effect on knowledge and nutritional status in children under five years of age. *Al GIZZAI: Public Health Nutrition Journal*, 4(2), 178–188.
- Shannon, E., et al. (2024). *Advanced maternal health practice: Integrating evidence into clinical care*. Springer.
- Sharma, A., & Singh, T. G. (2025). *Maternal and child health and nutrition*. Springer Nature.
- Silbert-Flagg, J. (2022). *Maternal & child health nursing: Care of the childbearing and childrearing family* (9th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- World Health Organization. (2023). *WHO recommendations on maternal and newborn care*. WHO Press.
- World Health Organization. (2023). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. WHO Press.

I. Glosarium

Antenatal Care (ANC)	:	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil secara teratur untuk memantau kondisi ibu dan janin serta mendeteksi dini faktor risiko kehamilan.
Asuhan Kebidanan	:	Serangkaian pelayanan profesional yang diberikan bidan kepada perempuan, bayi, dan keluarga sepanjang siklus reproduksi, meliputi kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan bayi.
Asuhan Persalinan Aman	:	Pelayanan persalinan yang dilakukan sesuai standar kebidanan dengan menekankan keselamatan, kenyamanan, dan dukungan fisik serta psikologis bagi ibu dan bayi.
Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	:	Proses menyusui yang dimulai dalam satu jam pertama setelah bayi lahir dengan kontak kulit antara ibu dan bayi.
Kader Kesehatan	:	Anggota masyarakat yang dipilih dan dilatih untuk membantu pelaksanaan kegiatan kesehatan di tingkat komunitas, seperti posyandu.
Kelas Ibu Hamil	:	Kegiatan edukasi kelompok yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil dan keluarga dalam mempersiapkan kehamilan, persalinan, dan nifas.
Pemantauan Tumbuh Kembang	:	Kegiatan penilaian pertumbuhan fisik dan perkembangan anak secara berkala untuk mendeteksi dini adanya gangguan.
Pengabdian Kebidanan	:	Bentuk pelayanan dan kontribusi bidan kepada masyarakat melalui kegiatan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Posyandu	:	Upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola bersama oleh masyarakat dan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Rujukan Kebidanan	:	Proses pengalihan tanggung jawab pelayanan dari bidan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila ditemukan komplikasi atau risiko tinggi.

CHAPTER 2

EDUKASI DAN PROMOSI KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS

Dwi Setiyawati, S.St.,M.Fis.

A. Pendahuluan / Prolog

Transformasi sistem kesehatan global dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran orientasi pelayanan dari pendekatan kuratif menuju paradigma promotif dan preventif yang lebih komprehensif. Tingginya beban penyakit tidak menular, peningkatan gangguan kesehatan mental, serta dampak sosial-ekonomi pascapandemi memperlihatkan bahwa intervensi klinis semata tidak cukup untuk menjawab kompleksitas masalah kesehatan masyarakat. Laporan global menegaskan bahwa determinan sosial, perilaku, dan lingkungan berkontribusi signifikan terhadap status kesehatan populasi, sehingga strategi berbasis komunitas menjadi semakin relevan dalam memperkuat pelayanan primer (World Health Organization (Nutbeam & Lloyd, 2021; WHO, 2021). Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya.

Promosi kesehatan berbasis komunitas berkembang sebagai respons atas keterbatasan pendekatan *top-down* yang sering kali kurang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Kajian sistematis menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan partisipasi komunitas secara bermakna cenderung menghasilkan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan dibandingkan intervensi yang bersifat instruksional satu arah (Haldane et al., 2020; Oles, Strydom, et al., 2024). Bukti empiris juga mengindikasikan bahwa keberhasilan program kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program (Mohamed et al., 2023). Konteks tersebut

menegaskan bahwa edukasi kesehatan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan struktur komunitas tempat intervensi dilakukan.

Literasi kesehatan menjadi salah satu fondasi utama dalam pengembangan edukasi berbasis komunitas. Kemampuan individu untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan berhubungan erat dengan kualitas pengambilan keputusan terkait perilaku sehat dan pemanfaatan layanan kesehatan (Nutbeam & Lloyd, 2021; Sørensen et al., 2021). Tingkat literasi kesehatan yang rendah berkontribusi pada ketimpangan kesehatan, terutama pada kelompok rentan dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan sumber informasi. Intervensi edukasi yang dirancang secara kontekstual dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan literasi kesehatan sekaligus memperkuat kapasitas kolektif komunitas dalam menghadapi risiko kesehatan (Odone et al., 2020; WHO, 2021).

Pendekatan berbasis komunitas juga selaras dengan penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai pilar sistem kesehatan yang inklusif. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program kesehatan mendorong terbentuknya rasa memiliki (*sense of ownership*) yang berkontribusi pada keberlanjutan intervensi (Rifkin, 2020; WHO, 2021). Studi pada berbagai negara berpendapatan rendah dan menengah menunjukkan bahwa model pemberdayaan komunitas dapat meningkatkan cakupan layanan promotif serta memperbaiki indikator kesehatan populasi secara signifikan (Haldane et al., 2020; Mohamed et al., 2023). Realitas ini memperlihatkan bahwa keberhasilan promosi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh konten edukasi, tetapi juga oleh kualitas relasi antara tenaga kesehatan dan komunitas.

Perkembangan teknologi digital turut memperluas ruang lingkup promosi kesehatan berbasis komunitas. Integrasi media sosial, aplikasi kesehatan, dan *platform* komunikasi daring memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas, sekaligus membuka peluang partisipasi interaktif (Odone et al., 2020; WHO, 2022). Transformasi digital menghadirkan tantangan baru terkait kesenjangan akses dan literasi digital, namun pada saat yang sama memberikan potensi besar

untuk memperkuat jejaring komunitas dan memperluas jangkauan edukasi kesehatan. Adaptasi strategi promosi kesehatan terhadap dinamika digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam konteks pelayanan kesehatan modern.

Bab ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif konsep, strategi, dan implikasi praktis edukasi serta promosi kesehatan berbasis komunitas dalam kerangka penguatan peran tenaga kesehatan. Pembahasan diarahkan pada integrasi perspektif teoretis dan bukti empiris mutakhir guna membangun model pendekatan yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan. Analisis dalam bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual sekaligus panduan aplikatif bagi tenaga kesehatan dalam mengembangkan intervensi yang responsif terhadap kebutuhan komunitas dan tantangan kesehatan kontemporer.

B. Konseptualisasi Edukasi dan Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan dipahami sebagai proses yang memungkinkan individu dan komunitas meningkatkan kontrol atas determinan kesehatan serta memperbaiki kualitas hidupnya. Perkembangan konseptual mutakhir menempatkan promosi kesehatan bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan strategi sosial yang melibatkan perubahan struktur, kebijakan, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku Kesehatan (Oles, Strydom, et al., 2024; WHO, 2021). Perspektif ini memperluas makna edukasi kesehatan dari aktivitas instruksional menjadi proses pemberdayaan yang berorientasi pada transformasi sosial. Promosi kesehatan dalam konteks komunitas menuntut keterlibatan kolektif, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas lokal agar perubahan yang terjadi tidak bersifat sementara.

Edukasi kesehatan sebagai bagian integral dari promosi kesehatan memiliki peran strategis dalam membentuk literasi kesehatan masyarakat. Literasi kesehatan mencakup kemampuan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi serta kapasitas individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan secara efektif (Nutbeam & Lloyd, 2021; Sørensen et al., 2021). Bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat literasi kesehatan yang memadai berhubungan

dengan peningkatan perilaku preventif, kepatuhan terapi, serta pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih tepat (Odone et al., 2020; WHO, 2021). Pendekatan edukatif yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman komunitas terbukti lebih efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan dibandingkan metode ceramah satu arah.

Konseptualisasi berbasis komunitas juga tidak dapat dilepaskan dari teori pemberdayaan (*empowerment theory*). Pemberdayaan dipahami sebagai proses yang memungkinkan individu dan kelompok memperoleh kendali terhadap keputusan dan tindakan yang memengaruhi kesehatannya (Haldane et al., 2020; Rifkin, 2020). Dalam praktik promosi kesehatan, pemberdayaan tercermin melalui partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi masalah, perencanaan solusi, hingga evaluasi program. Model partisipatif tersebut berkontribusi terhadap peningkatan rasa kepemilikan dan keberlanjutan intervensi kesehatan di tingkat lokal (Mohamed et al., 2023; WHO, 2021).

Determinasi sosial kesehatan menjadi landasan penting dalam memahami urgensi pendekatan komunitas. Faktor seperti pendidikan, kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, serta akses terhadap informasi digital memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatannya (Nutbeam & Lloyd, 2021; WHO, 2022). Intervensi edukasi yang tidak mempertimbangkan konteks sosial berisiko menghasilkan kesenjangan dampak dan memperlebar ketidaksetaraan kesehatan. Promosi kesehatan berbasis komunitas berupaya menjawab tantangan tersebut melalui strategi yang sensitif terhadap nilai budaya, norma sosial, serta struktur relasi dalam masyarakat.

Pendekatan ekologi sosial turut memperkaya konseptualisasi promosi kesehatan. Model ini memandang perilaku kesehatan sebagai hasil interaksi antara faktor individu, interpersonal, organisasi, komunitas, dan kebijakan publik (Haldane et al., 2020; Oles, Strydom, et al., 2024). Intervensi yang dirancang dengan mempertimbangkan berbagai lapisan determinan tersebut cenderung lebih komprehensif dan berkelanjutan. Edukasi kesehatan dalam kerangka ini tidak hanya

menyasar individu, tetapi juga memperkuat dukungan sosial, memperbaiki lingkungan, dan mendorong perubahan kebijakan yang mendukung perilaku sehat.

Perkembangan teknologi digital menambah dimensi baru dalam konseptualisasi promosi kesehatan komunitas. Integrasi media digital memungkinkan penyebaran pesan kesehatan yang lebih luas sekaligus membuka ruang partisipasi interaktif Masyarakat (Odone et al., 2020; WHO, 2022). Literasi digital menjadi bagian dari literasi kesehatan yang harus diperhatikan dalam perancangan program edukasi. Transformasi ini menuntut tenaga kesehatan untuk mengembangkan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi, sehingga promosi kesehatan tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan komunitas yang terus berubah.

C. Kerangka Teoretis Pendekatan Berbasis Komunitas

Pendekatan berbasis komunitas dalam promosi kesehatan berangkat dari asumsi bahwa kesehatan merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antara individu, lingkungan, dan struktur sosial. Literatur terkini menegaskan bahwa keberhasilan intervensi kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan komunitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Cyril et al., 2021; Gilmore et al., 2020). Partisipasi yang bersifat kolaboratif meningkatkan legitimasi sosial program sekaligus memperkuat kapasitas kolektif masyarakat. Perspektif ini menempatkan komunitas bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai mitra strategis dalam produksi pengetahuan dan solusi kesehatan.

Teori pemberdayaan (*empowerment theory*) memberikan fondasi normatif sekaligus operasional dalam pendekatan komunitas. Pemberdayaan dipahami sebagai proses peningkatan kontrol individu dan kelompok terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk aspek Kesehatan (Laverack, 2021; Wallerstein et al., 2020). Dalam konteks promosi kesehatan, pemberdayaan tercermin melalui penguatan kapasitas lokal, pengembangan kepemimpinan

komunitas, serta redistribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan kesehatan. Studi evaluatif menunjukkan bahwa intervensi berbasis pemberdayaan berhubungan dengan peningkatan partisipasi sosial, perubahan perilaku kesehatan, dan keberlanjutan program dalam jangka Panjang (Cyril et al., 2021; Wallerstein et al., 2020).

Model ekologi sosial (*social ecological model*) memperluas kerangka analisis dengan menempatkan perilaku kesehatan dalam sistem multilapis. Perubahan perilaku tidak dapat dilepaskan dari pengaruh relasi interpersonal, norma sosial, institusi, serta kebijakan publik (Gilmore et al., 2020; McLeroy et al., 2021). Pendekatan ini mendorong tenaga kesehatan untuk merancang intervensi yang simultan pada berbagai level determinan, termasuk penguatan dukungan keluarga, mobilisasi organisasi lokal, dan advokasi kebijakan. Integrasi kerangka ekologi sosial memungkinkan program promosi kesehatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dibandingkan intervensi yang hanya berfokus pada individu.

Community-based participatory research (CBPR) menjadi pendekatan metodologis yang memperkaya kerangka teoretis berbasis komunitas. CBPR menekankan kolaborasi setara antara peneliti, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam seluruh siklus program, mulai dari identifikasi masalah hingga diseminasi hasil (Gilmore et al., 2020; Wallerstein et al., 2020). Pendekatan ini terbukti meningkatkan relevansi intervensi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan. Model partisipatif tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan lokal memiliki nilai strategis dalam merancang solusi kesehatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Perspektif berbasis aset komunitas (*asset-based community development*) turut memperkaya pendekatan ini dengan menggeser fokus dari kekurangan menuju potensi lokal. Komunitas dipandang memiliki sumber daya sosial, budaya, dan struktural yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Kesehatan (Morgan & Ziglio, 2020; South et al., 2020). Identifikasi aset seperti kader kesehatan, tokoh agama, kelompok swadaya, dan jejaring sosial memungkinkan intervensi yang lebih

adaptif dan partisipatif. Pendekatan berbasis aset terbukti memperkuat kohesi sosial serta meningkatkan keberlanjutan program promosi kesehatan.

Perkembangan transformasi digital menuntut perluasan kerangka teoretis berbasis komunitas. Integrasi teknologi informasi dalam promosi kesehatan memperluas jangkauan edukasi sekaligus menciptakan ruang partisipasi baru melalui media sosial dan *platform* daring (Budd et al., 2020; Viswanath et al., 2022). Tantangan terkait kesenjangan literasi digital dan misinformasi menegaskan perlunya pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya. Kerangka teoretis yang adaptif terhadap dinamika digital memberikan landasan bagi pengembangan model promosi kesehatan komunitas yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara konseptual, pendekatan berbasis komunitas merupakan integrasi dinamis antara teori pemberdayaan, ekologi sosial, partisipasi kolaboratif, dan optimalisasi aset lokal. Kerangka ini menyediakan dasar ilmiah bagi tenaga kesehatan dalam merancang intervensi edukasi yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial komunitas untuk menjaga kesehatan secara mandiri dan kolektif.

D. Strategi Implementasi Edukasi dan Promosi Kesehatan Berbasis Komunitas

Implementasi edukasi dan promosi kesehatan berbasis komunitas memerlukan pendekatan sistematis yang diawali dengan analisis kebutuhan dan pemetaan sosial secara komprehensif. Community assessment menjadi langkah fundamental untuk mengidentifikasi masalah prioritas, karakteristik demografis, struktur sosial, serta potensi sumber daya lokal yang dapat dioptimalkan (Cyril et al., 2021; South et al., 2020). Pendekatan partisipatif dalam proses asesmen meningkatkan akurasi identifikasi masalah sekaligus membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program yang dirancang. Data kuantitatif perlu dipadukan dengan eksplorasi kualitatif guna memahami nilai budaya, norma sosial, dan persepsi risiko kesehatan yang berkembang dalam komunitas.

Perancangan intervensi edukatif harus bersifat kontekstual dan berbasis bukti ilmiah. Intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, tingkat literasi kesehatan, serta dinamika lokal terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku (Nutbeam & Lloyd, 2021; Oles, Smith, et al., 2024). Strategi komunikasi perlu mempertimbangkan bahasa, simbol budaya, serta saluran komunikasi yang paling relevan bagi komunitas sasaran. Pendekatan berbasis teori perubahan perilaku seperti *social ecological framework* atau *empowerment model* memungkinkan integrasi faktor individu dan struktural dalam desain program (Gilmore et al., 2020; Laverack, 2021).

Pemanfaatan kader kesehatan dan peer educator menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan edukasi. Kader yang berasal dari komunitas memiliki keunggulan dalam membangun kepercayaan, memahami konteks sosial, serta menjembatani komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat (Gilmore et al., 2020; Wallerstein et al., 2020). Pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kualitas pesan kesehatan yang disampaikan tetap akurat dan berbasis evidensi. Model peer education juga terbukti efektif dalam intervensi kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit tidak menular, serta promosi perilaku hidup sehat pada kelompok remaja dan dewasa muda (Cyril et al., 2021; Viswanath et al., 2022).

Integrasi teknologi digital memperluas strategi implementasi promosi kesehatan komunitas. Media sosial, aplikasi kesehatan, dan platform pesan instan memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan interaktif (Budd et al., 2020; Viswanath et al., 2022). Strategi digital perlu dirancang secara etis dan mempertimbangkan kesenjangan literasi digital agar tidak memperlebar ketidaksetaraan akses informasi. Kombinasi pendekatan tatap muka dan digital (*blended approach*) memberikan fleksibilitas sekaligus menjaga kualitas interaksi sosial yang menjadi kekuatan utama pendekatan komunitas.

Kolaborasi lintas sektor menjadi elemen strategis dalam memperkuat implementasi program. Kemitraan dengan pemerintah desa, organisasi masyarakat,

institusi pendidikan, dan sektor swasta memungkinkan mobilisasi sumber daya yang lebih luas (South et al., 2020; WHO, 2021). Pendekatan kolaboratif meningkatkan legitimasi program dan memperluas dampak intervensi di tingkat populasi. Kejelasan peran, komunikasi yang transparan, dan mekanisme koordinasi yang efektif menjadi prasyarat keberhasilan kolaborasi tersebut.

Monitoring dan evaluasi partisipatif merupakan komponen penting dalam memastikan keberlanjutan program. Evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian output, tetapi juga pada proses partisipasi, perubahan kapasitas komunitas, serta dampak jangka panjang terhadap indikator Kesehatan (Oles, Strydom, et al., 2024; Wallerstein et al., 2020). Pelibatan komunitas dalam proses evaluasi memperkuat akuntabilitas dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan refleksi bersama. Strategi implementasi yang adaptif dan responsif terhadap umpan balik lokal akan meningkatkan peluang keberhasilan program dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, strategi implementasi edukasi dan promosi kesehatan berbasis komunitas menuntut integrasi antara asesmen partisipatif, desain kontekstual, penguatan kapasitas lokal, pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas sektor, serta evaluasi berkelanjutan. Pendekatan yang sistematis dan inklusif tersebut memberikan peluang bagi tenaga kesehatan untuk mengembangkan model intervensi yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan dalam berbagai konteks komunitas.

E. Tantangan dan Hambatan Implementasi

Implementasi edukasi dan promosi kesehatan berbasis komunitas tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural yang memengaruhi efektivitas program. Keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta dukungan kebijakan sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan intervensi promotif di tingkat komunitas. Sistem kesehatan di banyak negara masih berorientasi pada pelayanan kuratif sehingga alokasi anggaran untuk program promotif–preventif relatif terbatas (Allen et al., 2020; WHO, 2022). Ketidakseimbangan prioritas ini berdampak pada

keberlanjutan program komunitas yang sering kali bergantung pada proyek jangka pendek.

Hambatan sosial dan budaya juga memengaruhi penerimaan intervensi kesehatan. Nilai, norma, dan kepercayaan lokal dapat membentuk persepsi risiko maupun sikap terhadap program kesehatan tertentu. Ketidaksesuaian pesan edukasi dengan konteks budaya berpotensi menimbulkan resistensi atau partisipasi yang rendah (Airhihenbuwa et al., 2020; Gilmore et al., 2020). Pendekatan yang tidak sensitif terhadap dinamika sosial komunitas dapat memperlemah hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Tantangan ini menuntut strategi komunikasi yang adaptif serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi program.

Kesenjangan literasi kesehatan dan literasi digital menjadi hambatan signifikan dalam era transformasi teknologi. Akses terhadap informasi kesehatan melalui platform digital belum merata dan sering kali dipengaruhi oleh faktor pendidikan, usia, serta kondisi sosial ekonomi (van Kessel et al., 2022; Viswanath et al., 2022). Penyebaran *misinformasi* kesehatan melalui media sosial semakin memperumit proses edukasi komunitas. Kondisi tersebut menuntut tenaga kesehatan untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kapasitas kritis masyarakat dalam memilah dan memverifikasi sumber informasi kesehatan.

Aspek kapasitas tenaga kesehatan sendiri turut menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Tidak semua tenaga kesehatan memiliki kompetensi dalam fasilitasi partisipatif, komunikasi risiko, atau pemberdayaan komunitas. Pendidikan dan pelatihan yang masih berfokus pada pendekatan klinis sering kali belum memberikan bekal yang cukup dalam pengembangan intervensi berbasis komunitas (Laverack, 2021; Wallerstein et al., 2020). Kesenjangan kompetensi ini dapat menghambat proses kolaboratif dan menurunkan efektivitas program promosi kesehatan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan program. Banyak intervensi komunitas menunjukkan hasil positif dalam jangka pendek, namun mengalami penurunan efektivitas ketika dukungan eksternal berkurang.

Faktor kepemimpinan lokal, stabilitas jejaring kemitraan, serta integrasi program ke dalam sistem pelayanan primer menjadi determinan utama keberlanjutan (Allen et al., 2020; South et al., 2020). Strategi institusionalisasi yang jelas, program berisiko berhenti setelah fase implementasi awal selesai.

Kompleksitas tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi edukasi dan promosi kesehatan berbasis komunitas memerlukan pendekatan adaptif dan reflektif. Identifikasi hambatan sejak tahap perencanaan, penguatan kapasitas lokal, serta dukungan kebijakan yang konsisten menjadi prasyarat penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan intervensi. Pemahaman kritis terhadap dinamika sosial, budaya, struktural, dan teknologi akan membantu tenaga kesehatan merancang strategi yang lebih responsif terhadap realitas komunitas yang terus berkembang.

F. Model Adaptif dan Berkelanjutan dalam Promosi Kesehatan Komunitas

Pengembangan model promosi kesehatan berbasis komunitas yang adaptif dan berkelanjutan menuntut integrasi antara fleksibilitas program dan penguatan sistem lokal. Adaptivitas merujuk pada kemampuan program untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial, perubahan epidemiologi, serta kebutuhan komunitas yang terus berkembang. Literatur implementasi kesehatan menekankan bahwa intervensi yang responsif terhadap konteks lokal memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan model yang kaku dan seragam (Hawe et al., 2020; Shelton et al., 2020). Proses adaptasi tersebut perlu dilakukan tanpa menghilangkan komponen inti berbasis evidensi agar kualitas intervensi tetap terjaga.

Keberlanjutan program berkaitan erat dengan integrasi intervensi ke dalam struktur pelayanan kesehatan primer dan tata kelola lokal. Program yang terinstitusionalisasi dalam sistem kesehatan cenderung memiliki daya tahan lebih lama dibandingkan intervensi berbasis proyek jangka pendek (Scheirer & Dearing, 2021; Shelton et al., 2020). Dukungan kebijakan, komitmen kepemimpinan lokal, serta mekanisme pendanaan yang konsisten menjadi determinan utama

keberlanjutan. Keterlibatan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam perencanaan strategis memperkuat legitimasi dan stabilitas program di tingkat komunitas.

Pendekatan *co-creation* dan *participatory governance* memperkaya model adaptif dalam promosi kesehatan. Kolaborasi setara antara tenaga kesehatan, pemangku kebijakan, dan komunitas memungkinkan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan berbasis kebutuhan nyata (Palumbo, 2021; Wallerstein et al., 2020). Model ini tidak hanya meningkatkan relevansi intervensi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan komunitas terhadap program yang dijalankan. Penguatan kapasitas kepemimpinan lokal menjadi komponen penting agar komunitas mampu mempertahankan program secara mandiri.

Pemanfaatan data dan teknologi digital juga mendukung adaptivitas dan keberlanjutan. Sistem monitoring berbasis data memungkinkan evaluasi berkala terhadap capaian program serta identifikasi kebutuhan penyesuaian strategi (Budd et al., 2020; WHO, 2021). *Platform digital* dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik komunitas secara *real-time*, memperluas jangkauan edukasi, dan memperkuat jejaring kolaboratif. Integrasi teknologi perlu disertai penguatan literasi digital agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara setara.

Pendekatan berbasis aset komunitas berkontribusi pada keberlanjutan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang telah tersedia. Identifikasi dan mobilisasi kader kesehatan, kelompok swadaya, serta tokoh masyarakat memperkuat fondasi sosial program (Morgan & Ziglio, 2020; South et al., 2020). Strategi ini mengurangi ketergantungan pada dukungan eksternal dan mendorong kemandirian komunitas dalam menjaga kesehatan kolektif. Model berbasis aset juga meningkatkan kohesi sosial dan solidaritas sebagai modal sosial yang penting dalam keberlanjutan program kesehatan.

Secara konseptual, model adaptif dan berkelanjutan dalam promosi kesehatan komunitas menuntut keseimbangan antara inovasi, partisipasi, dan institusionalisasi. Program yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan

konteks, mengintegrasikan dukungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas lokal memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang. Tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator perubahan yang memastikan proses adaptasi tetap berbasis evidensi dan selaras dengan kebutuhan komunitas.

G. Implikasi Praktis bagi Tenaga Kesehatan

Implementasi promosi kesehatan berbasis komunitas menuntut transformasi peran tenaga kesehatan dari sekadar pemberi layanan klinis menjadi fasilitator pemberdayaan. Dalam konteks pelayanan kesehatan primer, tenaga kesehatan perlu mengembangkan kompetensi komunikasi partisipatif, advokasi kebijakan lokal, serta kemampuan membangun jejaring lintas sektor. Literatur terbaru menegaskan bahwa tenaga kesehatan yang berperan sebagai *change agent* mampu meningkatkan keberhasilan intervensi berbasis komunitas melalui pendekatan kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Kok et al., 2022; WHO, 2021). Perubahan paradigma ini memerlukan penguatan kurikulum pendidikan kesehatan agar lebih menekankan kompetensi promotif–preventif dan pendekatan sosial-ekologis.

Secara operasional, tenaga kesehatan perlu mengintegrasikan asesmen sosial komunitas dalam praktik rutin. Identifikasi determinan sosial kesehatan, struktur kepemimpinan lokal, serta modal sosial komunitas menjadi dasar perencanaan intervensi yang kontekstual (Marmot et al., 2020; Perry et al., 2021). Pendekatan ini mendorong intervensi yang tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku individu, tetapi juga pada perbaikan lingkungan sosial yang memengaruhi kesehatan. Dengan demikian, program promosi kesehatan menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Penguatan kemitraan lintas sektor juga merupakan implikasi strategis. Tenaga kesehatan perlu menjalin kolaborasi dengan pemerintah desa, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan intervensi. Studi implementasi menunjukkan bahwa kemitraan multisektoral meningkatkan

efektivitas program pencegahan penyakit tidak menular serta memperkuat keberlanjutan kebijakan kesehatan local (Allen et al., 2020; Rasanathan et al., 2021). Dalam praktiknya, tenaga kesehatan berperan sebagai koordinator yang menyelaraskan tujuan kesehatan dengan agenda pembangunan lokal.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital perlu menjadi bagian dari praktik promotif tenaga kesehatan. Penggunaan media sosial, aplikasi kesehatan, dan sistem monitoring berbasis komunitas dapat memperluas akses informasi dan meningkatkan partisipasi Masyarakat (Budd et al., 2020; van Kessel et al., 2022). Namun, implementasi teknologi harus disertai edukasi literasi digital agar tidak memperlebar kesenjangan akses informasi kesehatan. Pendekatan hibrida—menggabungkan metode tatap muka dan digital—menjadi strategi yang relevan di berbagai konteks sosial.

Dari perspektif profesionalisme, tenaga kesehatan perlu mengembangkan refleksi praktik dan evaluasi berkelanjutan. Penggunaan kerangka evaluasi implementasi, seperti RE-AIM atau *Consolidated Framework for Implementation Research* (CFIR), dapat membantu menilai dampak, jangkauan, dan keberlanjutan program (Holtrop et al., 2021; Shelton et al., 2020). Evaluasi yang sistematis tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga menyediakan data untuk perbaikan program secara adaptif. Dengan demikian, praktik promosi kesehatan berbasis komunitas menjadi proses dinamis yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, implikasi praktis bagi tenaga kesehatan mencakup penguatan kompetensi pemberdayaan, integrasi asesmen sosial, pengembangan kemitraan lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, dan penerapan evaluasi berkelanjutan. Peran ini menempatkan tenaga kesehatan sebagai katalis perubahan sosial yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan.

H. Simpulan

Promosi kesehatan berbasis komunitas merupakan pendekatan strategis dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer karena mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, adaptasi kontekstual, kemitraan multisektoral, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam satu kerangka yang sistemik. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu, tetapi juga menysasar determinan sosial kesehatan dan mendorong institusionalisasi program dalam tata kelola lokal. Model yang adaptif dan berkelanjutan menuntut keterlibatan aktif komunitas, dukungan kebijakan yang konsisten, serta evaluasi implementasi yang berkelanjutan agar intervensi tetap relevan, efektif, dan mampu mengurangi kesenjangan kesehatan secara kolektif.

Penguatan promosi kesehatan berbasis komunitas memerlukan integrasi kebijakan yang jelas di tingkat daerah melalui pengarusutamaan pendekatan ini dalam rencana pembangunan dan sistem pelayanan kesehatan primer, disertai alokasi pendanaan yang berkelanjutan. Selain itu, institusionalisasi peran tenaga kesehatan sebagai fasilitator pemberdayaan perlu diwujudkan melalui reformulasi kurikulum pendidikan dan pelatihan yang menekankan kompetensi komunikasi partisipatif, advokasi komunitas, serta kolaborasi lintas sektor. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu membangun mekanisme kemitraan multisektoral yang formal dan terstruktur agar determinan sosial kesehatan dapat ditangani secara komprehensif. Pemanfaatan teknologi digital hendaknya dikembangkan secara inklusif dengan penguatan literasi digital masyarakat untuk mencegah kesenjangan akses informasi. Seluruh kebijakan dan program tersebut perlu disertai sistem monitoring dan evaluasi berbasis implementasi guna memastikan efektivitas, jangkauan, dan keberlanjutan intervensi dalam jangka panjang.

I. Referensi

- Airhihenbuwa, C. O., Iwelunmor, J., Munodawafa, D., Ford, C. L., Oni, T., Agyemang, C., Mota, C., Ikuenobe, M., & Ezechi, O. (2020). Culture matters in communicating the global response to COVID-19. *Preventing Chronic Disease*, 17, E60. <https://doi.org/10.5888/pcd17.200245>
- Allen, L. N., Nicholson, B. D., Yeung, B. Y. T., & Goiana-da-Silva, F. (2020). Implementation of non-communicable disease policies: A geopolitical analysis of 151 countries. *The Lancet Global Health*, 8(1), e50--e58. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30446-2](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30446-2)
- Budd, J., Miller, B. S., Manning, E. M., Lamos, V., Zhuang, M., Edelstein, M., Rees, G., Emery, V. C., Stevens, M. M., Keegan, N., Short, M. J., Pillay, D., Manley, E., & Cox, I. J. (2020). Digital technologies in the public-health response to COVID-19. *Nature Medicine*, 26(8), 1183–1192. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1011-4>
- Cyril, S., Smith, B. J., Possamai-Inesedy, A., & Renzaho, A. M. N. (2021). Exploring the role of community engagement in improving the health of disadvantaged populations: A systematic review. *Global Health Action*, 14(1), 1908169. <https://doi.org/10.1080/16549716.2021.1908169>
- Gilmore, B., Ndejjo, R., Tchetchia, A., de Claro, V., Mago, E., Diallo, A. A., Lopes, C., & Bhattacharyya, S. (2020). Community engagement for COVID-19 prevention and control: A rapid evidence synthesis. *BMJ Global Health*, 5(10), e003188. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003188>
- Haldane, V., Chuah, F. L. H., Srivastava, A., Singh, S. R., Koh, G. C. H., Seng, C. K., & Legido-Quigley, H. (2020). Community participation in health services development, implementation, and evaluation. *PLOS ONE*, 15(5), e0233652. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233652>
- Hawe, P., Shiell, A., & Riley, T. (2020). Complex interventions: How “out of control” can a randomised controlled trial be? *BMJ*, 328, 1561–1563. <https://doi.org/10.1136/bmj.328.7455.1561>
- Holtrop, J. S., Rabin, B. A., & Glasgow, R. E. (2021). Qualitative approaches to use of the RE-AIM framework: Rationale and methods. *BMC Health Services Research*, 21, 555. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06564-7>
- Kok, M. C., Dieleman, M., Taegtmeyer, M., & Broerse, J. E. W. (2022). Which intervention design factors influence performance of community health

- workers? *Health Policy and Planning*, 37(4), 450–463.
<https://doi.org/10.1093/heapol/czab174>
- Laverack, G. (2021). Revisiting community empowerment: Definitions and dilemmas. *Global Health Promotion*, 28(1), 45–52.
<https://doi.org/10.1177/1757975920904148>
- Marmot, M., Allen, J., Boyce, T., Goldblatt, P., & Morrison, J. (2020). *Health Equity in England: The Marmot Review 10 Years On*. Institute of Health Equity.
- McLeroy, K. R., Bibeau, D., Steckler, A., & Glanz, K. (2021). An ecological perspective on health promotion programs. *Health Education & Behavior*, 48(6), 673–679.
<https://doi.org/10.1177/10901981211036515>
- Mohamed, N. A., Abdelaal, A., & El-Gilany, A. H. (2023). Community-based interventions for non-communicable disease prevention in primary health care: A systematic review. *BMC Public Health*, 23, 1124.
<https://doi.org/10.1186/s12889-023-16075-3>
- Morgan, A., & Ziglio, E. (2020). Revitalising the evidence base for public health: An assets model. *Promotion & Education*, 17(2), 17–22.
<https://doi.org/10.1177/1025382310366839>
- Nutbeam, D., & Lloyd, J. E. (2021). Understanding and responding to health literacy as a social determinant of health. *Annual Review of Public Health*, 42, 159–173.
<https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102529>
- Odone, A., Buttigieg, S., Ricciardi, W., Azzopardi-Muscat, N., & Staines, A. (2020). Public health digitalization in Europe: E-health, digital health literacy and community engagement. *European Journal of Public Health*, 30(Supplement_5), v19–v23. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165>
- Oles, M., Smith, A., & Johnson, K. (2024). Strengthening community capacity in primary health care: Impacts on maternal and child health outcomes. *International Journal for Equity in Health*, 23, 45.
<https://doi.org/10.1186/s12939-024-02045-7>
- Oles, M., Strydom, M., & Rensburg, H. C. J. van. (2024). Community-based health promotion programs and their effectiveness: A global systematic review. *Health Promotion International*, 39(1), daad156.
<https://doi.org/10.1093/heapro/daad156>
- Palumbo, R. (2021). Co-production as a driver of health system sustainability: An

empirical study. *Sustainability*, 13(3), 1216.
<https://doi.org/10.3390/su13031216>

- Perry, H. B., Zulliger, R., & Rogers, M. M. (2021). Community health workers in low-, middle-, and high-income countries. *Annual Review of Public Health*, 42, 399–421. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102830>
- Rasanathan, K., Bennett, S., Atkins, V., Beschel, R., Carrasquilla, G., Evans, T., Goenka, S., & Jha, A. (2021). Governing multisectoral action for health in low- and middle-income countries. *PLoS Medicine*, 18(4), e1003559. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003559>
- Rifkin, S. B. (2020). Paradigms lost: Toward a new understanding of community participation in health programmes. *Acta Tropica*, 202, 105197. <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2019.105197>
- Scheirer, M. A., & Dearing, J. W. (2021). An agenda for research on the sustainability of public health programs. *American Journal of Public Health*, 111(1), 12–18. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.305913>
- Shelton, R. C., Cooper, B. R., & Stirman, S. W. (2020). The sustainability of evidence-based interventions and practices in public health and health care. *Annual Review of Public Health*, 41, 55–76. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040119-094524>
- Sørensen, K., den Broucke, S., & Fullam, J. (2021). Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health*, 21, 1204. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11278-4>
- South, J., Giuntoli, G., Kinsella, K., & Carthy, J. (2020). Asset-based approaches and health improvement. *Health & Social Care in the Community*, 28(4), 1185–1193. <https://doi.org/10.1111/hsc.12964>
- van Kessel, R., Wong, B. L. H., Rubinić, I., O’Nuallain, E., & Czabanowska, K. (2022). Is Europe prepared to go digital? *The Lancet Regional Health -- Europe*, 12, 100276. <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100276>
- Viswanath, K., Bekalu, M., Dhawan, D., Pinnamaneni, R., Lang, J., & McCloud, R. (2022). Individual and social determinants of COVID-19 vaccine uptake. *BMC Public Health*, 22, 818. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13174-8>
- Wallerstein, N., Duran, B., Oetzel, J., & Minkler, M. (2020). Community-based participatory research for health. *American Journal of Public Health*, 110(S2),

S168--S170. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.305718>

WHO. (2021). *Community engagement: A health promotion guide for universal health coverage in the hands of the people*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240010529>

WHO. (2022). *Global report on health equity for persons with disabilities*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240063600>

J. Glosarium

Adaptivitas Program

Kemampuan suatu intervensi kesehatan untuk menyesuaikan strategi, metode, dan implementasinya sesuai dengan perubahan konteks sosial, budaya, epidemiologis, dan kebijakan tanpa menghilangkan komponen inti berbasis evidensi.

Asset-Based Approach (Pendekatan Berbasis Aset)

Pendekatan promosi kesehatan yang menekankan identifikasi dan pemanfaatan kekuatan, sumber daya, dan potensi yang telah dimiliki komunitas sebagai modal utama peningkatan kesehatan.

Community-Based Participatory Research (CBPR)

Pendekatan penelitian kolaboratif yang melibatkan komunitas sebagai mitra setara dalam seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Community Engagement (Keterlibatan Komunitas)

Proses partisipatif yang melibatkan individu dan kelompok masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program kesehatan untuk meningkatkan relevansi dan keberlanjutan intervensi.

Community Empowerment (Pemberdayaan Komunitas)

Proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam komunitas untuk mengontrol determinan kesehatan dan mengambil keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka.

Determinans Sosial Kesehatan (Social Determinants of Health)

Kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik yang memengaruhi status kesehatan individu maupun populasi, seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan lingkungan tempat tinggal.

Digital Health Literacy

Kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan melalui platform digital secara efektif dan kritis.

Ecological Model (Model Ekologis)

Kerangka teoretis dalam promosi kesehatan yang memandang perilaku kesehatan dipengaruhi oleh berbagai tingkat faktor, mulai dari individu, interpersonal, komunitas, hingga kebijakan publik.

Evidence-Based Intervention (Intervensi Berbasis Evidensi)

Program atau strategi kesehatan yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan bukti ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Health Equity (Keadilan Kesehatan)

Kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai derajat kesehatan optimal tanpa hambatan yang disebabkan oleh faktor sosial atau ekonomi.

Health Literacy (Literasi Kesehatan)

Kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan.

Implementasi Berbasis Komunitas

Proses penerapan program kesehatan dengan melibatkan struktur sosial dan sumber daya lokal sebagai bagian integral dari strategi intervensi.

Institusionalisasi Program

Proses integrasi program kesehatan ke dalam sistem, kebijakan, dan tata kelola lokal sehingga menjadi bagian permanen dari pelayanan rutin.

Kemitraan Multisektoral

Kolaborasi antara berbagai sektor (kesehatan, pendidikan, sosial, pemerintahan, swasta) untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat secara komprehensif.

Monitoring dan Evaluasi Implementasi

Proses sistematis untuk menilai efektivitas, jangkauan, keberlanjutan, dan dampak suatu program kesehatan dalam konteks nyata.

Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

Pendekatan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis komunitas, berfokus pada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Promosi Kesehatan Berbasis Komunitas

Strategi peningkatan kesehatan yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam identifikasi masalah, perencanaan solusi, dan evaluasi program.

RE-AIM Framework

Kerangka evaluasi implementasi yang menilai Reach (jangkauan), Effectiveness (efektivitas), Adoption (adopsi), Implementation (pelaksanaan), dan Maintenance (keberlanjutan) suatu program.

Sustainability (Keberlanjutan Program)

Kemampuan program kesehatan untuk terus berjalan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang setelah fase awal implementasi atau pendanaan eksternal berakhir.

Tenaga Kesehatan sebagai Change Agent

Peran tenaga kesehatan sebagai fasilitator perubahan sosial yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi komunitas dalam peningkatan kesehatan.

CHAPTER 3

KOLABORASI TENAGA KESEHATAN DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT

Yenda Hasnita, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan / Prolog

Kolaborasi tenaga kesehatan dalam pengabdian masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi berfungsi mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam praktik nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020). Dalam konteks kesehatan masyarakat, pengabdian menjadi wahana strategis untuk menangani berbagai permasalahan kompleks seperti masalah gizi, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang masih menjadi tantangan di banyak wilayah (World Health Organization, 2016).

Permasalahan kesehatan masyarakat bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, ekonomi, lingkungan, dan perilaku, sehingga tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui pendekatan satu profesi saja. Oleh karena itu, kolaborasi tenaga kesehatan atau interprofessional collaboration menjadi pendekatan yang sangat relevan dalam kegiatan pengabdian masyarakat (World Health Organization, 2010). Pendekatan ini menekankan kerja sama lintas profesi yang saling menghargai peran dan kompetensi masing-masing, serta terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas intervensi, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan (Reeves et al., 2017).

Pokok judul pengabdian masyarakat yang menekankan kolaborasi tenaga kesehatan mencerminkan pendekatan holistik dalam penanganan masalah kesehatan. Menurut Green dan Kreuter (2005), status kesehatan masyarakat sangat

dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan, selain faktor biologis. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, sanitarian, dan tenaga promosi kesehatan dalam satu kesatuan program memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan intervensi yang lebih komprehensif, mulai dari edukasi, pencegahan, deteksi dini, hingga rujukan dan pendampingan (World Health Organization, 2014).

Peran nyata tenaga kesehatan dalam masyarakat menjadi landasan utama keberhasilan pengabdian masyarakat. Tenaga kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif, tetapi juga sebagai pendidik, fasilitator, dan agen perubahan perilaku kesehatan di tingkat komunitas (Stanhope & Lancaster, 2020). Bidan berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, perawat dalam pemantauan dan perawatan komunitas, tenaga gizi dalam pencegahan masalah gizi, serta tenaga promosi kesehatan dalam membentuk perilaku hidup sehat, sehingga sinergi peran ini akan memperkuat dampak program pengabdian masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Dengan demikian, pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi tenaga kesehatan merupakan strategi yang efektif dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Melalui kerja sama lintas profesi, program pengabdian dapat menjangkau berbagai determinan kesehatan secara lebih menyeluruh dan mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatannya, sejalan dengan paradigma promotif dan preventif yang menjadi arah utama pembangunan kesehatan nasional dan global (World Health Organization, 2016; Kementerian Kesehatan RI, 2020).

B. Konsep Kolaborasi Tenaga Kesehatan

Kolaborasi tenaga kesehatan merupakan komponen kunci dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan modern yang kompleks dan multidimensi. Kolaborasi didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antar pemberi pelayanan kesehatan, di mana setiap profesi menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai

kompetensi dan ruang lingkup praktik masing-masing, namun tetap berada dalam satu kerangka tujuan yang sama, yaitu keselamatan dan kesejahteraan pasien serta masyarakat. Dalam praktik kolaborasi, tanggung jawab terhadap hasil layanan tidak dipandang sebagai beban satu profesi saja, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang diwujudkan melalui komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan secara bilateral maupun kolektif berdasarkan pendidikan, keahlian, dan kapasitas masing-masing praktisi (Keperawatan, 2021).

Secara lebih luas, kolaborasi tenaga kesehatan dipahami sebagai proses kerja sama terencana antara dua atau lebih profesi kesehatan yang memiliki latar belakang keilmuan, kewenangan, dan perspektif berbeda untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang sama. Kolaborasi ini dilakukan melalui mekanisme kerja tim yang terstruktur, pembagian peran yang jelas, serta pertukaran informasi yang akurat dan tepat waktu guna meningkatkan mutu intervensi kesehatan dan keselamatan pasien maupun masyarakat (World Health Organization/WHO, 2010). Dengan adanya kolaborasi, pelayanan kesehatan tidak hanya menjadi lebih efektif dan efisien, tetapi juga lebih holistik karena masalah kesehatan dipandang dari berbagai sudut—biologis, psikologis, sosial, budaya, hingga lingkungan.

Pendekatan kolaboratif bertumpu pada prinsip-prinsip dasar yang memastikan setiap profesi dapat bekerja optimal tanpa tumpang tindih atau konflik peran. Prinsip tersebut meliputi saling menghormati antarprofesi, kejelasan peran dan tanggung jawab, komunikasi yang terbuka dan setara, serta akuntabilitas profesional dalam menjalankan tugas masing-masing. Penerapan prinsip ini membantu meminimalkan miskomunikasi, mengurangi fragmentasi layanan, serta meningkatkan efektivitas kerja tim dalam merespons kebutuhan kesehatan individu dan komunitas (Reeves et al., 2017). Dalam konteks praktik, kolaborasi yang baik ditandai oleh adanya koordinasi yang jelas, kesepakatan target kerja, serta evaluasi bersama terhadap hasil yang dicapai.

Kolaborasi juga menekankan kesetaraan peran dalam tim interprofesional, artinya tidak ada profesi yang dianggap “lebih penting” secara absolut, melainkan

setiap profesi memiliki kontribusi unik sesuai kompetensinya. Model ini mendorong proses shared decision making, di mana keputusan klinis atau keputusan program tidak diambil secara sepihak, tetapi melalui diskusi bersama dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang profesional. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan cenderung lebih komprehensif, realistis, dan kontekstual terhadap kondisi pasien maupun masyarakat yang dilayani (Barr et al., 2005). Dalam tim kesehatan, kolaborasi semacam ini juga memperkuat budaya saling belajar (interprofessional learning) dan mendorong peningkatan kapasitas anggota tim secara berkelanjutan.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi tenaga kesehatan memiliki makna yang semakin luas karena tidak hanya berfokus pada pelayanan klinis individual, melainkan mencakup seluruh tahapan kegiatan berbasis komunitas. Kolaborasi diperlukan sejak tahap awal, yaitu identifikasi masalah kesehatan, pemetaan kebutuhan dan faktor risiko di masyarakat, hingga tahap perencanaan program yang sesuai dengan karakteristik lokal. Kolaborasi lintas profesi sejak awal akan meningkatkan ketepatan sasaran intervensi, karena setiap profesi dapat menyumbang perspektif yang berbeda dalam menilai masalah dan menentukan strategi yang paling efektif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, kolaborasi membantu memastikan bahwa kegiatan promotif, preventif, kuratif dasar, maupun rehabilitatif dapat berjalan terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien.

Selain itu, kolaborasi lintas profesi sangat penting untuk memperkuat pendekatan promotif dan preventif yang menjadi pilar utama pembangunan kesehatan masyarakat. Melalui sinergi tenaga kesehatan, kegiatan seperti edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, skrining dan deteksi dini penyakit, konseling gizi, promosi kesehatan reproduksi, hingga pendampingan pengelolaan penyakit kronis dapat dirancang sebagai paket program yang saling melengkapi dan berkelanjutan. Hasil akhirnya diharapkan bukan hanya peningkatan pengetahuan, tetapi juga perubahan perilaku, peningkatan literasi kesehatan, serta terbentuknya kemandirian

masyarakat dalam menjaga kesehatannya (WHO, 2010). Kolaborasi juga memungkinkan pelaksanaan program yang lebih responsif terhadap kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, lansia, dan penderita penyakit kronis.

Lebih jauh, kolaborasi tenaga kesehatan dalam pengabdian masyarakat menuntut adanya kemitraan lintas sektor di luar bidang kesehatan. Kolaborasi yang efektif tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan pemangku kepentingan lokal, seperti kader kesehatan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, dan pemerintah setempat. Kemitraan ini menjadi krusial karena pemangku kepentingan lokal memiliki pengaruh dalam menggerakkan partisipasi warga, membangun kepercayaan, serta memastikan program dapat dilanjutkan setelah kegiatan pengabdian selesai. Dalam kerangka promosi kesehatan, kemitraan lintas sektor juga membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku, misalnya melalui kebijakan desa, penyediaan sarana, atau penguatan regulasi lokal (Green & Kreuter, 2005).

Dengan demikian, kolaborasi tenaga kesehatan merupakan landasan konseptual yang esensial dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keberhasilan program kesehatan berbasis komunitas. Kolaborasi memungkinkan penanganan masalah kesehatan secara holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sehingga mendukung tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat bukan hanya meningkatkan capaian program, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan melalui kerja tim yang efektif, penguatan jejaring layanan, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam menjaga kesehatannya (Reeves et al., 2017).

C. Landasan Teoritis Kolaborasi Tenaga Kesehatan

Kolaborasi tenaga kesehatan berlandaskan pada konsep *Interprofessional Collaboration* (IPC), yaitu suatu pendekatan praktik profesional yang melibatkan dua atau lebih profesi kesehatan untuk bekerja secara kolaboratif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan. IPC bertujuan untuk meningkatkan

kualitas layanan, keselamatan masyarakat, serta hasil kesehatan melalui koordinasi peran dan pengambilan keputusan bersama antarprofesi. World Health Organization (2010) menegaskan bahwa IPC merupakan strategi utama dalam memperkuat sistem kesehatan, khususnya dalam menghadapi tantangan kompleks seperti penyakit kronis, masalah kesehatan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya.

Konsep IPC menekankan beberapa komponen utama, antara lain komunikasi efektif antarprofesi, kejelasan peran dan tanggung jawab, saling menghargai kompetensi profesional, serta komitmen terhadap tujuan bersama. Penerapan komponen-komponen tersebut memungkinkan terciptanya praktik pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa praktik kolaboratif interprofesional berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kepuasan penerima layanan kesehatan (Reeves et al., 2017).

Interprofessional Collaboration tidak dapat dilepaskan dari konsep *Interprofessional Education* (IPE), yang merupakan proses pembelajaran di mana mahasiswa atau tenaga kesehatan dari berbagai profesi belajar bersama, dari, dan tentang satu sama lain untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Barr et al. (2005) menyatakan bahwa IPE merupakan fondasi utama dalam membangun kompetensi kolaboratif, seperti komunikasi antarprofesi, kerja tim, dan pengambilan keputusan bersama, yang diperlukan dalam praktik kolaboratif di lapangan.

Penerapan IPE sejak tahap pendidikan formal hingga pendidikan berkelanjutan bertujuan untuk membentuk sikap profesional yang terbuka terhadap kolaborasi lintas disiplin. Melalui pengalaman belajar bersama, calon tenaga kesehatan diharapkan mampu memahami peran dan kontribusi profesi lain, sehingga dapat mengurangi ego sektoral dan meningkatkan efektivitas kerja tim dalam pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, IPE berfungsi sebagai

prasyarat penting bagi implementasi IPC yang efektif dan berkelanjutan (WHO, 2010).

Selain IPC dan IPE, kolaborasi interprofesional juga didukung oleh pendekatan sistem kesehatan (*health systems approach*), yang memandang kesehatan masyarakat sebagai hasil interaksi dinamis berbagai subsistem, seperti pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan, kebijakan, serta peran masyarakat. Swanwick et al. (2014) menjelaskan bahwa sistem kesehatan yang efektif memerlukan koordinasi dan integrasi antarprofesi serta lintas sektor untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal dan berkelanjutan.

Pendekatan sistem kesehatan menempatkan kolaborasi lintas profesi sebagai elemen fundamental dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, pendekatan ini mendorong keterlibatan berbagai tenaga kesehatan secara terpadu dalam merancang dan melaksanakan intervensi kesehatan berbasis komunitas. Sinergi antarprofesi memungkinkan respons yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan secara berkelanjutan (Swanwick et al., 2014).

D. Peran Tenaga Kesehatan dalam Kolaborasi Pengabdian Masyarakat

Kolaborasi tenaga kesehatan dalam pengabdian masyarakat menuntut keterlibatan aktif berbagai profesi kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Sinergi lintas profesi memungkinkan penanganan masalah kesehatan masyarakat secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pembagian peran yang jelas dalam tim kolaboratif menjadi prasyarat utama agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat sasaran (World Health Organization (WHO), 2010).

1. Dokter

Dokter berperan sebagai penanggung jawab aspek medis dalam kegiatan pengabdian masyarakat, termasuk penegakan diagnosis awal, pelaksanaan

skrining kesehatan, serta penentuan rujukan klinis bagi masyarakat yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Peran ini sangat penting untuk menjamin bahwa intervensi kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar medis dan prinsip keselamatan pasien (WHO, 2010).

Selain peran klinis, dokter juga berkontribusi dalam penyusunan materi edukasi kesehatan yang berbasis bukti ilmiah serta pengambilan keputusan medis yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam tim kolaboratif, dokter berperan sebagai mitra profesional yang bekerja bersama tenaga kesehatan lain untuk merancang intervensi yang komprehensif dan berorientasi pada pencegahan penyakit (Reeves et al., 2017).

2. Perawat

Perawat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan asuhan keperawatan komunitas, pendampingan keluarga, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat masyarakat. Peran ini mencakup pengkajian kebutuhan kesehatan individu dan keluarga, pelaksanaan intervensi keperawatan berbasis komunitas, serta evaluasi respons masyarakat terhadap kegiatan pengabdian (Stanhope & Lancaster, 2016).

Dalam kolaborasi pengabdian masyarakat, perawat juga berfungsi sebagai penghubung antara tim kesehatan dan masyarakat. Kedekatan peran perawat dengan individu dan keluarga memungkinkan terjalinnya komunikasi yang efektif, peningkatan kepercayaan masyarakat, serta penguatan partisipasi aktif dalam program kesehatan yang dilaksanakan (Kemenkes RI, 2020).

3. Bidan

Bidan berfokus pada pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan keluarga, khususnya dalam upaya promotif dan preventif kesehatan reproduksi. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, bidan berperan dalam memberikan pelayanan antenatal, konseling kesehatan reproduksi, serta edukasi tentang perawatan ibu dan bayi sesuai dengan standar praktik kebidanan (International Confederation of Midwives, 2014).

Selain itu, bidan memiliki peran penting dalam pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, serta pemberdayaan perempuan dan keluarga. Melalui pendekatan yang berorientasi pada keluarga dan komunitas, bidan berkontribusi dalam menurunkan risiko komplikasi kehamilan dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam jangka panjang (Kemenkes RI, 2020).

4. Tenaga Gizi

Tenaga gizi berperan dalam identifikasi masalah gizi masyarakat melalui pengukuran status gizi, analisis pola konsumsi pangan, serta penilaian faktor risiko gizi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tenaga gizi menyusun dan melaksanakan intervensi gizi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, termasuk edukasi gizi seimbang dan konseling gizi (Gibson, 2005).

Peran tenaga gizi sangat penting dalam kegiatan pengabdian masyarakat untuk menurunkan prevalensi masalah gizi, khususnya pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak. Intervensi gizi yang terintegrasi dengan peran tenaga kesehatan lain berkontribusi terhadap peningkatan status gizi dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (World Health Organization, 2013).

5. Tenaga Kesehatan Masyarakat

Tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam analisis situasi kesehatan, perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi dampak kegiatan pengabdian. Peran ini mencakup pengumpulan dan analisis data kesehatan, penentuan prioritas masalah, serta perancangan strategi intervensi yang efektif dan efisien (Green & Kreuter, 2005).

Pendekatan promosi dan pemberdayaan masyarakat menjadi kekuatan utama tenaga kesehatan masyarakat dalam kolaborasi lintas profesi. Melalui strategi pemberdayaan, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kesehatan dan mengembangkan kemandirian dalam menjaga kesehatannya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

6. Tenaga Farmasi

Tenaga farmasi berperan dalam edukasi penggunaan obat yang rasional, pencegahan kesalahan penggunaan obat, serta pengelolaan obat di tingkat komunitas. Peran ini mencakup pemberian informasi obat yang tepat, pemantauan kepatuhan penggunaan obat, serta edukasi tentang efek samping dan interaksi obat (World Health Organization, 2011).

Dalam kolaborasi pengabdian masyarakat, tenaga farmasi berkontribusi penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap terapi serta menjamin keselamatan penggunaan obat. Sinergi antara tenaga farmasi dan profesi kesehatan lainnya mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Reeves et al., 2017).

E. Bentuk dan Model Kolaborasi dalam Pengabdian Masyarakat

Kolaborasi tenaga kesehatan dalam pengabdian masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Salah satu bentuk yang paling umum adalah edukasi kesehatan terpadu, yaitu kegiatan penyuluhan dan promosi kesehatan yang melibatkan beberapa profesi kesehatan secara bersamaan. Dalam pendekatan ini, setiap profesi memberikan kontribusi sesuai dengan kompetensinya, sehingga pesan kesehatan yang disampaikan menjadi lebih menyeluruh dan mudah dipahami oleh masyarakat (WHO, 2010).

Selain edukasi kesehatan, bentuk kolaborasi lainnya adalah pelaksanaan skrining kesehatan terpadu. Skrining dilakukan untuk mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan, baik penyakit menular maupun tidak menular, dengan melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu. Kolaborasi dalam kegiatan skrining memungkinkan penilaian kondisi kesehatan masyarakat secara lebih akurat, karena mencakup aspek klinis, perilaku kesehatan, serta faktor lingkungan dan sosial yang memengaruhi kesehatan (WHO, 2010).

Bentuk kolaborasi berikutnya adalah pendampingan kelompok rentan, seperti ibu hamil, lansia, remaja, dan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah.

Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan promotif dan preventif yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan dasar. Dalam konteks ini, kolaborasi antarprofesi berperan penting dalam memberikan dukungan komprehensif, baik dari aspek kesehatan fisik, psikologis, maupun sosial (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Dari sisi model, kolaborasi dalam pengabdian masyarakat dapat berbentuk tim interprofesional terpadu. Model ini ditandai dengan pembentukan satu tim yang terdiri atas berbagai profesi kesehatan yang bekerja secara terkoordinasi dalam satu program pengabdian. Tim interprofesional terpadu memungkinkan komunikasi yang intensif, pengambilan keputusan bersama, serta pembagian peran yang jelas, sehingga efektivitas intervensi kesehatan dapat ditingkatkan secara signifikan (Reeves et al., 2017).

Model kolaborasi lainnya adalah jejaring kolaboratif lintas sektor yang melibatkan institusi kesehatan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat. Jejaring ini memungkinkan integrasi sumber daya, pengetahuan, dan kebijakan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan lintas sektor menjadi penting karena permasalahan kesehatan masyarakat bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai determinan di luar sektor kesehatan (Green & Kreuter, 2005).

Selain itu, kolaborasi dalam pengabdian masyarakat juga dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan institusi non-kesehatan, seperti pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat. Kemitraan ini berfungsi untuk memperkuat dukungan sosial, meningkatkan keberterimaan program di tingkat komunitas, serta mendorong keberlanjutan kegiatan pengabdian setelah program selesai dilaksanakan. Model kemitraan tersebut sejalan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan kesehatan (Green & Kreuter, 2005).

F. Implementasi Kolaborasi pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Implementasi kolaborasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan proses identifikasi masalah kesehatan masyarakat secara partisipatif. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat sasaran, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lokal untuk menggali permasalahan kesehatan yang nyata dan dirasakan bersama. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pengabdian yang dirancang relevan dengan kebutuhan lokal, konteks sosial budaya, serta potensi sumber daya yang tersedia di masyarakat (Kemenkes RI, 2020).

Identifikasi masalah kesehatan masyarakat dilakukan melalui berbagai metode, seperti survei lapangan, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam, serta analisis data kesehatan setempat. Keterlibatan lintas profesi tenaga kesehatan dalam tahap ini memungkinkan pemetaan masalah kesehatan secara komprehensif dari berbagai sudut pandang keilmuan, sehingga prioritas intervensi dapat ditetapkan secara lebih tepat dan berbasis bukti (Green & Kreuter, 2005).

Tahap selanjutnya adalah perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat secara kolaboratif. Pada tahap ini, seluruh anggota tim lintas profesi berpartisipasi dalam penyusunan tujuan, strategi intervensi, indikator keberhasilan, serta rencana operasional kegiatan. Perencanaan bersama memungkinkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan, sehingga menghindari tumpang tindih tugas dan meningkatkan efektivitas kerja tim (Reeves et al., 2017).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan mengedepankan koordinasi dan komunikasi antaranggota tim kolaboratif. Setiap profesi kesehatan melaksanakan perannya sesuai dengan rencana yang telah disepakati, namun tetap terbuka terhadap penyesuaian berdasarkan dinamika dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Integrasi peran ini memungkinkan pemberian layanan dan intervensi kesehatan yang holistik, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara seimbang (WHO, 2010).

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap penting dalam implementasi kolaborasi pengabdian masyarakat yang dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai capaian tujuan, efektivitas intervensi, serta dampak program terhadap masyarakat. Keterlibatan seluruh profesi kesehatan dalam proses evaluasi memungkinkan analisis hasil kegiatan secara komprehensif dan menjadi dasar perbaikan program di masa mendatang (Reeves et al., 2017).

Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi kolaboratif berfungsi sebagai bahan refleksi bersama bagi tim pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas kolaborasi lintas profesi. Umpan balik dari masyarakat juga menjadi komponen penting dalam evaluasi, karena memberikan gambaran nyata mengenai tingkat penerimaan, manfaat, dan keberlanjutan program yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, implementasi kolaborasi dalam pengabdian masyarakat tidak hanya berorientasi pada pencapaian output jangka pendek, tetapi juga pada dampak dan keberlanjutan program kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2020).

G. Tantangan dalam Kolaborasi Tenaga Kesehat

Salah satu tantangan utama dalam kolaborasi tenaga kesehatan adalah perbedaan persepsi, nilai profesional, dan pola kerja antarprofesi. Setiap profesi kesehatan memiliki latar belakang pendidikan, budaya organisasi, serta kerangka berpikir yang berbeda dalam memandang masalah kesehatan. Perbedaan ini sering kali menimbulkan miskomunikasi, tumpang tindih peran, maupun konflik kewenangan apabila tidak dikelola secara sistematis melalui mekanisme kolaborasi yang jelas (Barr et al., 2005).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, waktu, maupun pendanaan. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan beban kerja yang tinggi sering kali menyulitkan pelaksanaan kolaborasi secara optimal. Kondisi ini

diperparah dengan keterbatasan fasilitas dan logistik di wilayah sasaran, khususnya pada daerah terpencil atau dengan akses layanan kesehatan yang terbatas (WHO, 2010).

Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif juga menjadi hambatan signifikan dalam kolaborasi tenaga kesehatan. Komunikasi yang tidak terstruktur dan minimnya forum koordinasi antarprofesi dapat menyebabkan ketidaksinambungan intervensi serta rendahnya efektivitas program pengabdian. Tanpa sistem komunikasi yang jelas, proses pengambilan keputusan bersama menjadi sulit, sehingga potensi kolaborasi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal (Reeves et al., 2017).

Selain faktor individu dan tim, tantangan kolaborasi juga bersumber dari aspek kebijakan dan sistem organisasi. Belum optimalnya dukungan kebijakan institusional, seperti regulasi yang mengatur praktik kolaboratif dan pembagian peran lintas profesi, dapat menghambat implementasi kolaborasi di lapangan. Sistem organisasi yang masih bersifat sektoral dan hierarkis sering kali membatasi ruang bagi kerja sama yang setara antarprofesi dalam kegiatan pengabdian masyarakat (WHO, 2010).

Lebih lanjut, kurangnya pengalaman dan pelatihan kolaboratif sejak tahap pendidikan turut memperkuat tantangan dalam praktik kolaborasi. Tanpa bekal kompetensi kolaboratif yang memadai, tenaga kesehatan cenderung bekerja secara individual atau profesi-sentris. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi konsep Interprofessional Education (IPE) sebagai landasan penguatan kolaborasi tenaga kesehatan dalam konteks pengabdian masyarakat (Barr et al., 2005).

H. Strategi Penguatan Kolaborasi Tenaga Kesehatan

Penguatan kolaborasi tenaga kesehatan memerlukan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan, salah satunya melalui pelatihan interprofesional secara kontinu. Pelatihan interprofesional dirancang untuk meningkatkan pemahaman lintas profesi, membangun kompetensi komunikasi kolaboratif, serta menumbuhkan

sikap saling menghargai antaranggota tim. Melalui pelatihan ini, tenaga kesehatan diharapkan mampu bekerja secara efektif dalam tim interprofesional, baik pada konteks pelayanan kesehatan maupun kegiatan pengabdian masyarakat (Swanwick, Forrest, & O'Brien, 2014).

Selain pelatihan, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) kolaboratif menjadi strategi penting dalam memperkuat praktik kolaborasi. SOP kolaboratif berfungsi sebagai pedoman kerja yang menjelaskan peran, tanggung jawab, dan alur komunikasi antarprofesi dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian masyarakat. Kejelasan SOP tidak hanya meminimalkan tumpang tindih peran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kerja tim kesehatan (WHO, 2010).

Penguatan kepemimpinan tim interprofesional juga merupakan elemen strategis dalam mendorong kolaborasi yang efektif. Pemimpin tim diharapkan mampu memfasilitasi komunikasi terbuka, mengelola perbedaan pendapat, serta memastikan partisipasi aktif seluruh anggota tim. Kepemimpinan yang inklusif dan adaptif berperan penting dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi kolaborasi lintas profesi, khususnya dalam konteks pengabdian masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Swanwick et al., 2014).

Di tingkat organisasi, dukungan institusi menjadi faktor penentu keberhasilan penguatan kolaborasi tenaga kesehatan. Institusi kesehatan dan pendidikan perlu menyediakan struktur organisasi, sumber daya, serta sistem penghargaan yang mendorong praktik kolaboratif. Tanpa dukungan institusional yang memadai, upaya penguatan kolaborasi cenderung bersifat sporadis dan sulit berkelanjutan (WHO, 2010).

Selain dukungan institusi, kebijakan yang mendukung praktik kolaboratif juga memiliki peran strategis. Kebijakan yang jelas dan berpihak pada kerja sama lintas profesi, termasuk regulasi pembagian peran dan kewenangan, akan memperkuat legitimasi kolaborasi tenaga kesehatan di lapangan. Kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan

kolaborasi berjalan secara efektif dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat (WHO, 2010).

I. Dampak Kolaborasi terhadap Keberhasilan Pengabdian Masyarakat

Kolaborasi tenaga kesehatan yang efektif memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Melalui kerja sama lintas profesi, intervensi kesehatan dapat dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek medis, keperawatan, gizi, farmasi, dan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan yang lebih aman, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga kualitas hasil pengabdian dapat ditingkatkan secara optimal. Selain peningkatan kualitas layanan, kolaborasi juga berkontribusi terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya. Pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang baik antarprofesi memungkinkan penggunaan sumber daya manusia, waktu, dan biaya secara lebih efektif. Dengan menghindari duplikasi kegiatan dan memaksimalkan keahlian masing-masing profesi, program pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan dengan cakupan yang lebih luas tanpa meningkatkan beban sumber daya secara signifikan (Reeves et al., 2017).

Dampak penting lainnya dari kolaborasi tenaga kesehatan adalah meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat. Pendekatan kolaboratif mendorong keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatannya secara mandiri (Green & Kreuter, 2005).

Kolaborasi lintas profesi dan lintas sektor juga berperan dalam meningkatkan keberlanjutan program pengabdian masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal, program pengabdian tidak berhenti pada satu periode kegiatan

saja. Sinergi antaraktor tersebut memungkinkan integrasi program ke dalam sistem dan struktur lokal, sehingga manfaat pengabdian dapat dirasakan dalam jangka panjang (Green & Kreuter, 2005).

Lebih lanjut, keberhasilan pengabdian masyarakat melalui kolaborasi tenaga kesehatan turut berkontribusi pada penguatan sistem kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Praktik kolaboratif yang konsisten dapat menjadi model kerja yang direplikasi pada program kesehatan lainnya, baik di tingkat komunitas maupun kebijakan. Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya berdampak pada keberhasilan program pengabdian, tetapi juga menjadi strategi strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan (Reeves et al., 2017).

J. Simpulan

Kolaborasi tenaga kesehatan merupakan pendekatan strategis dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk menjawab kompleksitas permasalahan kesehatan. Sinergi lintas profesi memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan intervensi kesehatan yang lebih holistik, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Penguatan kolaborasi perlu didukung melalui pendidikan interprofesional, praktik kolaboratif yang sistematis, serta kebijakan dan dukungan institusi yang kondusif. Dengan demikian, kolaborasi tenaga kesehatan dapat berkontribusi secara berkelanjutan dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat.

K. Referensi

- Barr, H., Koppel, I., Reeves, S., Hammick, M., & Freeth, D. (2005). *Effective interprofessional education: Argument, assumption and evidence*. Oxford: Blackwell Publishing.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470776445>
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health program planning: An educational and ecological approach* (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
<https://www.mheducation.com/highered/product/health-program-planning-green/M9780072556834.html>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman promosi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. <https://promkes.kemkes.go.id/pedoman-promosi-dan-pemberdayaan-masyarakat-bidang-kesehatan>
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (6), CD000072. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub3>
- Swanwick, T., McKimm, J., & O'Sullivan, H. (2014). *Understanding medical education: Evidence, theory and practice*. Oxford: Wiley Blackwell. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119373780>
- World Health Organization. (2010). *Framework for action on interprofessional education and collaborative practice*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/framework-for-action-on-interprofessional-education-collaborative-practice>

L. Glosarium

WUS	= Wanita Usia Subur
IPC	= Interprofessional Collaboration
IPE	= Interprofessional Education
WHO	= World Health Organization

CHAPTER 4

DAMPAK PENGABDIAN TERHADAP PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

A. Pendahuluan / Prolog

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Masyarakat yang sehat akan mampu berperan secara optimal dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Namun demikian, berbagai permasalahan kesehatan masih menjadi tantangan serius, terutama di negara berkembang, seperti tingginya angka penyakit menular dan tidak menular, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta kesenjangan pengetahuan kesehatan di masyarakat (WHO, 2016).

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup mereka (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Dalam konteks kesehatan, pengabdian masyarakat berperan penting sebagai sarana promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan dalam penerapan perilaku hidup sehat. Pendekatan berbasis komunitas dalam pengabdian kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kesehatan, sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatannya (Green & Kreuter, 2005).

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat di bidang kesehatan dapat memberikan dampak positif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut meliputi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, perubahan perilaku kesehatan, penurunan faktor risiko penyakit, serta peningkatan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan (Notoatmodjo, 2012). Dengan demikian, pengabdian masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai strategi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

Selain itu, pengabdian kepada masyarakat juga menjadi wahana kolaborasi antara akademisi, tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi kesehatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dapat diterima secara sosial dan budaya (Rifkin, 2014). Pendekatan partisipatif dalam pengabdian kesehatan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan kesehatan.

B. Konsep dan Landasan Teoritis

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengabdian masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kegiatan sosial, tetapi sebagai pendekatan strategis untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi permasalahan sosial dan kesehatan (Kemenristekdikti, 2021).

Kesehatan masyarakat didefinisikan sebagai upaya kolektif yang terorganisir untuk melindungi, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan penduduk melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan kesehatan masyarakat modern menekankan pentingnya intervensi berbasis komunitas yang

berorientasi pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup, terutama pada kelompok rentan (World Health Organization [WHO], 2022).

Landasan teoretis utama dalam pengabdian kesehatan masyarakat adalah teori determinan sosial kesehatan (*social determinants of health*). WHO menegaskan bahwa status kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, serta akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Ketimpangan dalam determinan tersebut berkontribusi besar terhadap disparitas kesehatan antar kelompok masyarakat (WHO, 2021). Oleh karena itu, pengabdian masyarakat di bidang kesehatan harus dirancang secara kontekstual dan responsif terhadap kondisi sosial setempat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) menjadi teori penting dalam pelaksanaan pengabdian kesehatan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam mengontrol faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mereka. Penelitian terkini menunjukkan bahwa program kesehatan berbasis pemberdayaan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat keberlanjutan program, serta menghasilkan dampak kesehatan yang lebih signifikan dibandingkan pendekatan top-down (Laverack, 2020).

Selain itu, teori perubahan perilaku kesehatan menjadi dasar penting dalam merancang intervensi pengabdian masyarakat. Model seperti Health Belief Model, Theory of Planned Behavior, dan PRECEDE–PROCEED Model menjelaskan bahwa perubahan perilaku kesehatan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, sikap, norma sosial, serta dukungan lingkungan. Penerapan model ini dalam pengabdian kesehatan memungkinkan penyusunan program yang lebih sistematis dan berbasis kebutuhan masyarakat (Glanz et al., 2021).

Dalam konteks implementasi, pengabdian masyarakat di bidang kesehatan juga selaras dengan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung

pencapaian target SDGs melalui kegiatan pengabdian yang berfokus pada pencegahan penyakit, peningkatan literasi kesehatan, dan penguatan sistem kesehatan berbasis komunitas (United Nations, 2023).

C. Dampak Pengabdian terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut dapat dilihat dari perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menjaga kesehatan secara mandiri. Pengabdian yang dirancang berbasis kebutuhan komunitas terbukti lebih efektif dalam menghasilkan perubahan kesehatan yang berkelanjutan (Bourke et al., 2021).

Salah satu dampak utama pengabdian kesehatan adalah peningkatan literasi kesehatan masyarakat. Literasi kesehatan yang baik memungkinkan individu memahami informasi kesehatan, mengambil keputusan yang tepat, serta menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi pengabdian berbasis edukasi kesehatan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan penyakit, gizi seimbang, dan kesehatan lingkungan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan faktor risiko penyakit (Sørensen et al., 2021).

Selain aspek pengetahuan, pengabdian masyarakat juga berdampak signifikan terhadap perubahan perilaku kesehatan. Program pengabdian yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti pendampingan dan pelatihan berbasis komunitas, terbukti efektif dalam mendorong perubahan perilaku, termasuk peningkatan aktivitas fisik, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, serta praktik sanitasi yang lebih baik (Kok et al., 2022). Perubahan perilaku ini merupakan indikator penting dalam keberhasilan intervensi kesehatan masyarakat.

Dampak pengabdian juga tercermin pada peningkatan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan. Melalui kegiatan seperti skrining kesehatan, pelayanan kesehatan dasar, dan rujukan terintegrasi, pengabdian masyarakat membantu menjembatani kesenjangan akses layanan, terutama pada kelompok masyarakat rentan dan wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan (Marmot et al., 2020). Peningkatan akses ini berkontribusi pada deteksi dini penyakit dan pencegahan komplikasi kesehatan.

Dalam jangka panjang, pengabdian masyarakat di bidang kesehatan berperan dalam memperkuat ketahanan kesehatan komunitas (*community health resilience*). Ketahanan kesehatan mencerminkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, merespons, dan pulih dari berbagai tantangan kesehatan, termasuk wabah penyakit dan kondisi darurat kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa komunitas yang pernah terlibat aktif dalam program pengabdian kesehatan memiliki kesiapsiagaan dan kapasitas respons yang lebih baik terhadap krisis kesehatan (Patel et al., 2022).

Selain dampak kesehatan, pengabdian masyarakat juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Masyarakat yang lebih sehat cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan beban biaya kesehatan yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa investasi pada program kesehatan berbasis komunitas melalui pengabdian masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, baik bagi individu maupun sistem kesehatan secara keseluruhan (Health Systems Global, 2023).

D. Simpulan

Pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Berlandaskan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi komunitas, pengabdian kesehatan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga kesehatannya secara mandiri. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjawab

berbagai tantangan kesehatan masyarakat yang bersifat kompleks dan kontekstual (Kickbusch et al., 2022).

Dampak pengabdian kesehatan tercermin pada meningkatnya literasi kesehatan, perubahan perilaku preventif, serta penguatan ketahanan kesehatan komunitas. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, pengabdian masyarakat mampu mendukung pembangunan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat merupakan instrumen penting bagi perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian pembangunan kesehatan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan (UNDP, 2023).

E. Referensi

- Allen, L. N., Nicholson, B. D., Yeung, B. Y. T., & Goiana-da-Silva, F. (2022). Implementation of non-communicable disease policies: A systematic review. *The Lancet Global Health*, 10(2), e278–e287. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00511-9](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00511-9)
- Bambra, C., Lynch, J., & Smith, K. E. (2023). *The unequal pandemic: COVID-19 and health inequalities*. Policy Press.
- Bourke, S., Humphreys, J. S., Wakeman, J., & Taylor, J. (2021). Understanding rural and remote health: A framework for analysis in Australia. *Health & Place*, 70, 102556. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2021.102556>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Fridell, M., Edwin, S., von Schreeb, J., & Saulnier, D. D. (2021). Health system resilience: What are we talking about? A scoping review mapping characteristics and keywords. *International Journal of Health Policy and Management*, 10(1), 6–16. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.71>
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2021). *Health behavior: Theory, research, and practice* (6th ed.). Jossey-Bass.
- Health Systems Global. (2023). *Community health systems: Delivering for equity and resilience*. Health Systems Global.
- Kickbusch, I., Piselli, D., Agrawal, A., Balicer, R., Banner, O., Adelhardt, M., Capobianco, E., Fabian, C., Gill, A. S., Lupton, D., & Royston, G. (2022). The Lancet and Financial Times Commission on governing health futures 2030: Growing up in a digital world. *The Lancet*, 398(10312), 1727–1776. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01824-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01824-9)
- Kok, G., Peters, G.-J. Y., Kessels, L. T. E., ten Hoor, G. A., & Ruiter, R. A. C. (2022). Ignoring theory and misinterpreting evidence: The false belief in quick fixes for behavior change. *Health Psychology Review*, 16(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/17437199.2021.1957869>
- Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Kebijakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset*. Kemenristek/BRIN.

- Laverack, G. (2020). *Health promotion practice: Power and empowerment* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Marmot, M., Allen, J., Goldblatt, P., Herd, E., & Morrison, J. (2020). *Build back fairer: The COVID-19 Marmot review*. Institute of Health Equity.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.
- OECD. (2023). *Health for the people, by the people: Building resilient health systems*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/cb90f3b6-en>
- Patel, S. S., Rogers, M. B., Amlôt, R., & Rubin, G. J. (2022). What do we mean by “community resilience”? A systematic literature review of how it is defined in the literature. *PLoS Currents*, 14. <https://doi.org/10.1371/currents.dis.db775aff25efc5ac4f0660ad9c9f7db2>
- Rifkin, S. B. (2014). Examining the links between community participation and health outcomes: A review of the literature. *Health Policy and Planning*, 29(Suppl 2), ii98–ii106. <https://doi.org/10.1093/heapol/czu076>
- Sørensen, K., Pelikan, J. M., Röthlin, F., Ganahl, K., Slonska, Z., Doyle, G., Fullam, J., Kondilis, B., Agraftotis, D., Ueters, E., Falcon, M., Mensing, M., Tchamov, K., van den Broucke, S., & Brand, H. (2021). Health literacy in Europe: Comparative results of the European health literacy survey. *European Journal of Public Health*, 31(3), 410–416. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab007>
- United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals report 2023*. United Nations.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human development report 2023–2024*. UNDP.
- World Health Organization. (2010). *A conceptual framework for action on the social determinants of health*. WHO.
- World Health Organization. (2016). *Health in all policies (HiAP) framework for country action*. WHO.
- World Health Organization. (2021). *Social determinants of health*. WHO.
- World Health Organization. (2022). *Global health estimates 2019: Disease burden by cause, age, sex*. WHO.
- Winslow, C. E. A. (1920). The untilled fields of public health. *Science*, 51(1306), 23–33. <https://doi.org/10.1126/science.51.1306.23>

F. Glosarium

Akses Layanan Kesehatan = Kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara tepat waktu, terjangkau, dan berkualitas.

Community Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat) = Proses peningkatan kapasitas individu dan komunitas agar mampu mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka secara mandiri.

Community Health Resilience (Ketahanan Kesehatan Komunitas) = Kemampuan masyarakat untuk mencegah, merespons, dan pulih dari gangguan kesehatan, termasuk wabah penyakit dan kondisi darurat kesehatan.

Determinasi Sosial Kesehatan (Social Determinants of Health) = Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan budaya yang memengaruhi status kesehatan individu dan masyarakat.

Dampak Pengabdian Masyarakat = Perubahan positif yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam aspek pengetahuan, perilaku, status kesehatan, maupun kesejahteraan sosial.

Edukasi Kesehatan = Proses pemberian informasi dan pembelajaran kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menjaga kesehatan.

Kesehatan Masyarakat = Ilmu dan praktik yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, dan perlindungan kesehatan penduduk melalui pendekatan terorganisir dan berbasis komunitas.

Literasi Kesehatan = Kemampuan individu untuk mengakses, memahami, menilai, dan menggunakan informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan.

Partisipasi Masyarakat = Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan yang ditujukan bagi kepentingan bersama.

Pengabdian kepada Masyarakat = Kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) = Serangkaian perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.

Pembangunan Kesehatan = Upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Pendekatan Berbasis Komunitas = Strategi intervensi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan.

Promosi dan Pencegahan Kesehatan = Upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan serta mencegah terjadinya penyakit.

Sustainable Development Goals (SDGs) = Agenda pembangunan global yang bertujuan menjamin kesejahteraan manusia, termasuk tujuan ke-3 tentang kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi semua.

Tri Dharma Perguruan Tinggi = Tiga kewajiban utama perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



PROFIL PENULIS



Bdn. Nurul Lidya, SST, M.Kes. merupakan akademisi dan praktisi kebidanan yang memiliki komitmen kuat dalam pengembangan ilmu kebidanan dan kesehatan reproduksi Menyelesaikan pendidikan D III di Stikes MH. Thamrin tahun 2008, Menyelesaikan Pendidikan D IV di Universitas Padjajaran tahun 2010, Menyelesaikan Pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat dengan minat Kesehatan Reproduksi di Universitas Respati Indonesia tahun 2016, Menyelesaikan Pendidikan Profesi Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2023. Sejak tahun 2010 Penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan dan saat ini Penulis merupakan dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Penulis

juga aktif dalam penerbitan Buku Ajar, Bookchapter, Buku Referensi, Monograf serta pembuatan artikel pada jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email nurullidya03@gmail.com.

Motto: "Bidan bukan sekadar profesi, melainkan panggilan jiwa yang berakar pada ilmu yang kuat dan ketulusan pengabdian."



Dwi Setiyawati, S.St., M.Fis Lahir di Pemalang, 08 Desember 1978.. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma 3 Fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kemudian melanjutkan ke jenjang Diploma IV Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi di Universitas Esa Unggul Jakarta. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan S2 dalam Bidang Fisiologi Olahraga Konsentrasi Fisioterapi di Universitas Udayana Bali. Riwayat pekerjaan di awalai pada tahun 2002 di pelayanan klinik fisioterapi dan pada tahun 2007 sampai sekarang menjadi Dosen di Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas

Ilmu Kesehatan Universitas Al-Irsyad Cilacap. Penulis mempunyai bidang keahlian Fisioterapi Kardiovaskular Pulmonal. Selain sebagai praktisi dan akademisi, penulis juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan penyakit menular Tuberculosis (TBC) melalui pendekatan Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dwisetiyawati78@gmail.com



PROFIL PENULIS



Yenda Hasnita, S.Tr.Keb., M,Keb. Lahir di Solok, 20 Maret 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Kebidanan di Akbid Puteri Andalas Padang tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di STIKes Ranah Minang tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2019. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3 di Lincoln University College. Sejak tahun 2020, penulis berkiprah sebagai pendidik kebidanan dan saat ini merupakan dosen tetap Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Perintis Indonesia. Penulis aktif melaksanakan

Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, penulisan buku, serta pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan ilmiah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Perintis Indonesia mengampu berbagai mata kuliah seperti Pengantar Asuhan Kebidanan, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita, Pengantar Mom and Baby Spa, Mom and Baby Spa, Dokumentasi Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, dan kegiatan ilmiah Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yendahasnita93@gmail.com

Motto: "Teach to empower."



PROFIL PENULIS



Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes. Lahir di Grobogan, 05 Maret 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan Poltekkes Tasikmalaya dan lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan ke jenjang D4 Program Studi Sarjana Sains Terapan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta dan lulus tahun 2007. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Respati Indonesia pada tahun 2013.

Riwayat pekerjaan penulis dimulai setelah lulus D3 sebagai bidan praktik di berbagai fasilitas kesehatan dasar, kemudian bergabung sebagai tenaga pengajar di institusi pendidikan kesehatan. Saat ini

penulis menjabat sebagai Rektor sekaligus dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana (Kespro & KB), Kesehatan Dasar Pada Kehamilan (KDPK), serta Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Penulis telah menghasilkan berbagai penelitian di bidang kesehatan reproduksi remaja dan anemia gizi besi, serta aktif melakukan pengabdian masyarakat melalui edukasi kesehatan di sekolah-sekolah dan komunitas. Selain itu, penulis rutin mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi, serta menulis buku dan modul pembelajaran untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: srimusfiroh052@gmail.com

Motto: "Menjadi manusia yang berguna untuk orang lain"

Sinopsis

“Bunga Rampai: Pengabdian dan Peran Nyata Tenaga Kesehatan dalam Masyarakat” merupakan kumpulan tulisan yang menggambarkan kontribusi konkret tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dasar, dan rehabilitatif berbasis komunitas. Bookchapter ini menegaskan bahwa permasalahan kesehatan di masyarakat—seperti kesehatan ibu dan anak, stunting, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lansia, hingga kesehatan mental—tidak cukup diselesaikan hanya di fasilitas layanan kesehatan, tetapi memerlukan penguatan peran tenaga kesehatan langsung di lingkungan keluarga dan komunitas.

Melalui bunga rampai ini, pembaca diajak memahami bagaimana tenaga kesehatan berperan sebagai edukator, fasilitator, motivator, advokat, serta penghubung layanan kesehatan dengan masyarakat. Berbagai praktik pengabdian disajikan dengan menekankan proses yang sistematis: identifikasi masalah kesehatan berbasis kebutuhan lokal, perencanaan program, pelaksanaan intervensi yang kolaboratif, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dampak. Buku ini juga menyoroti pentingnya kemitraan dengan kader kesehatan, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, serta kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan program pengabdian.

Bookchapter ini ditujukan bagi mahasiswa kesehatan, tenaga kesehatan pemula, praktisi, pendidik, dan pengelola program sebagai referensi sekaligus inspirasi dalam merancang kegiatan pengabdian yang aplikatif, sensitif budaya, dan berorientasi pemberdayaan. Dengan pendekatan yang kontekstual dan mudah diterapkan, bunga rampai ini diharapkan dapat memperkuat peran tenaga kesehatan sebagai agen perubahan dan penggerak kemandirian masyarakat menuju kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Bunga Rampai: Pengabdian dan Peran Nyata Tenaga Kesehatan dalam Masyarakat” merupakan kumpulan tulisan yang menggambarkan kontribusi konkret tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dasar, dan rehabilitatif berbasis komunitas. Bookchapter ini menegaskan bahwa permasalahan kesehatan di masyarakat—seperti kesehatan ibu dan anak, stunting, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lansia, hingga kesehatan mental—tidak cukup diselesaikan hanya di fasilitas layanan kesehatan, tetapi memerlukan penguatan peran tenaga kesehatan langsung di lingkungan keluarga dan komunitas.

Melalui bunga rampai ini, pembaca diajak memahami bagaimana tenaga kesehatan berperan sebagai edukator, fasilitator, motivator, advokat, serta penghubung layanan kesehatan dengan masyarakat. Berbagai praktik pengabdian disajikan dengan menekankan proses yang sistematis: identifikasi masalah kesehatan berbasis kebutuhan lokal, perencanaan program, pelaksanaan intervensi yang kolaboratif, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dampak. Buku ini juga menyoroti pentingnya kemitraan dengan kader kesehatan, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, serta kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan program pengabdian.

Bookchapter ini ditujukan bagi mahasiswa kesehatan, tenaga kesehatan pemula, praktisi, pendidik, dan pengelola program sebagai referensi sekaligus inspirasi dalam merancang kegiatan pengabdian yang aplikatif, sensitif budaya, dan berorientasi pemberdayaan. Dengan pendekatan yang kontekstual dan mudah diterapkan, bunga rampai ini diharapkan dapat memperkuat peran tenaga kesehatan sebagai agen perubahan dan penggerak kemandirian masyarakat menuju kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan.



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

